



Kementerian PPN/
Bappenas

Pedoman Penghitungan

Indeks Modal Manusia

dan Capaian Tahun 2025



2026

Pedoman Penghitungan Indeks Modal Manusia dan Capaian Tahun 2025

© 2026 | Kementerian PPN/Bappenas

Cetakan Pertama: 2026

Pedoman Penghitungan Indeks Modal Manusia dan Capaian Tahun 2025

(51 + xii hlm: 176 × 250 mm)

Pedoman Penghitungan Indeks Modal Manusia dan Capaian Tahun 2025 ini merupakan hasil dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak. Kami menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Tanoto Foundation, Program Inovasi untuk Pendidikan Anak Indonesia (INOVASI), dan *World Bank* atas dukungan dan kontribusinya dalam penyusunan buku pedoman IMM dan penghitungan capaian tahun 2025 ini.

Diterbitkan oleh:

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kantor Bappenas: Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat 10310

Menara Bappenas: Jalan H. R. Rasuna Said No. Kav. B2, Jakarta Selatan 12920

Telepon/Fax: (021) 3905 650

Laman: <https://bappenas.go.id>

Sumber Ilustrasi:

Shutterstock

INOVASI

Sumber Foto:

Kementerian PPN/Bappenas

Tanoto Foundation

INOVASI

UNICEF

MCA Indonesia

Kata Sambutan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan



Pembangunan manusia terlihat dalam hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari: seorang ibu selamat melahirkan, bayi tumbuh tanpa kekurangan gizi, anak datang ke sekolah dan benar-benar belajar, serta orang dewasa sehat untuk bekerja dan menjalani keluarganya. Target kita bukan hanya panjang umur, tetapi harus panjang umur, sehat dan aktif. *Healthy Life Active Expectancy*. Karena itu, ukuran pembangunan manusia perlu melihat

bukan hanya kondisi hari ini, tetapi juga peluang yang sedang kita siapkan bagi generasi yang akan datang.

Indeks Modal Manusia (IMM) membantu kita membaca rangkaian tersebut. IMM menghubungkan kelangsungan hidup, pendidikan, dan kesehatan sejak awal kehidupan hingga usia produktif. Jika Indikator Pembangunan Manusia yang selama ini kita kenal adalah membantu melihat kondisi saat ini, maka IMM mengajak kita bertanya ke depan: dengan layanan kesehatan dan pendidikan yang diterima anak hari ini, seberapa besar potensi anak dapat dicapai ketika dewasa?

Hasil penghitungan IMM juga membantu mengarahkan perhatian kita pada dampak nyata pembangunan. Anak perlu bertahan hidup dan tumbuh sehat. Anak perlu memperoleh pendidikan yang bermutu, bukan sekadar hadir di sekolah. Anak juga perlu berkembang dalam lingkungan yang membentuk karakter, rasa percaya diri, tanggung jawab, dan kemampuan untuk hidup bersama. Semua itu akan menentukan kesempatan dan kemampuan seseorang ketika dewasa.

IMM juga menunjukkan bahwa kondisi setiap wilayah tidak sama. Ada daerah yang perlu memperkuat layanan ibu dan anak, ada yang harus mengejar mutu pembelajaran, dan ada yang memerlukan penanganan terpadu agar anak tidak keluar dari sekolah. Karena itu, data tentang anak, keluarga, sekolah, layanan kesehatan, dan kondisi wilayah perlu dibaca bersama, lalu diterjemahkan menjadi tindakan yang jelas dan terukur.

Buku pedoman ini perlu dibaca bersamaan dengan membaca jabatan perindikator IMM, data pendukung, dan pengalaman masyarakat di setiap wilayah. Dengan begitu, angka tidak berhenti menjadi laporan, tetapi menjadi petunjuk untuk

memperbaiki layanan dan memperbesar kesempatan setiap anak Indonesia. Setiap anak harus dijamin untuk tumbuh sehat, belajar dengan baik, membangun karakter, dan mencapai potensi terbaiknya.

Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kementerian PPN/ Bappenas, Badan Pusat Statistik, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, mitra pembangunan, para pakar, serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam pengembangan IMM dan penyusunan buku ini. Mari kita gunakan pedoman ini secara konsisten sebagai rujukan bersama dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan manusia yang presisi, berbasis data berkualitas, dan responsif terhadap kebutuhan setiap wilayah.

Jakarta, Agustus 2026

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan

Pratikno

Kata Sambutan

Menteri PPN/Kepala Bappenas



Untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur, Indonesia memerlukan sumber daya manusia yang unggul, sehat, cerdas, produktif, serta adaptif terhadap dinamika global. Oleh karena itu, pembangunan modal manusia menjadi fondasi utama dalam mewujudkan transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2025–2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, Pemerintah terus memperkuat investasi dalam pembangunan modal manusia.

Upaya peningkatan kualitas modal manusia memerlukan instrumen pengukuran yang mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian pembangunan manusia. Selama lebih dari tiga dekade, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kemajuan pembangunan manusia di Indonesia. Namun, seiring dengan tantangan pembangunan yang semakin kompleks, diperlukan pendekatan yang mampu menggambarkan kualitas sumber daya manusia sepanjang siklus kehidupan. Indeks Modal Manusia (IMM) dikembangkan sebagai pelengkap IPM dengan mengintegrasikan dimensi kelangsungan hidup, pendidikan, dan kesehatan dalam mengukur potensi produktivitas individu. Dengan pendekatan ini, pembangunan manusia dipandang sebagai investasi jangka panjang yang menjadi fondasi kemajuan bangsa.

Buku Pedoman Penghitungan Indeks Modal Manusia ini disusun sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memahami konsep, metodologi, indikator, serta tata cara penghitungan IMM. Melalui pedoman ini, penghitungan dan pemanfaatan IMM diharapkan dapat dilakukan secara konsisten, transparan, dan akuntabel sehingga menghasilkan informasi yang andal untuk penyusunan kebijakan, penetapan prioritas pembangunan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan modal manusia secara berkelanjutan.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, akademisi, mitra pembangunan, pakar, dan berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan Indeks Modal Manusia serta penyusunan buku ini. Kementerian PPN/Bappenas bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus memperkuat pemanfaatan IMM sebagai salah satu instrumen strategis dalam mendukung pembangunan modal manusia. Buku ini diharapkan menjadi referensi dalam menyelaraskan perencanaan dan pengambilan kebijakan yang lebih berkualitas, sehingga berkontribusi pada terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Jakarta, Agustus 2026

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Rachmat Pambudy



Kata Sambutan

Kepala Badan Pusat Statistik

Indeks Modal Manusia (IMM) merupakan instrumen penting dalam menilai pemenuhan hak dasar manusia untuk hidup sehat, memperoleh pendidikan yang bermutu, dan tumbuh produktif sepanjang siklus kehidupannya. Keunggulan IMM terletak pada kemampuannya menggambarkan bukan hanya kondisi saat ini, tetapi juga potensi produktivitas sumber daya manusia di masa depan. Dengan demikian, IMM menjadi pelengkap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan sekaligus alat strategis dalam perencanaan serta evaluasi pembangunan sumber daya manusia.

Meskipun demikian, sejumlah aspek dalam IMM perlu terus diperkuat. Pertama, metodologi IMM perlu dikaji secara berkelanjutan agar lebih mencerminkan kontribusi relatif tiap dimensi, sehingga tidak menimbulkan bias akibat ketergantungan pada satu indikator. Kedua, kualitas dan ketepatan waktu data harus terus ditingkatkan melalui integrasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi digital. Ketiga, indikator kesehatan ke depan perlu diperluas agar mencakup isu-isu seperti penyakit tidak menular dan kesehatan mental. Keempat, pemanfaatan IMM di tingkat daerah memerlukan panduan teknis yang lebih operasional agar dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam RPJMD dan RKPD.

Oleh karena itu, Pedoman Penghitungan Indeks Modal Manusia (IMM) disusun dengan menyesuaikan konteks nasional, sumber data, dan kebutuhan perencanaan pembangunan di Indonesia. Hingga saat ini, pengukuran dimensi kelangsungan hidup, pendidikan, dan kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi metodologi maupun kualitas data. Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Kesehatan terus berupaya meningkatkan akurasi, konsistensi, dan cakupan data melalui penguatan metodologi, peningkatan kualitas sumber data, serta penyempurnaan sistem pencatatan dan pengelolaan data. Upaya tersebut diharapkan dapat menghasilkan penghitungan IMM yang lebih akurat, konsisten, dan mampu mencerminkan kondisi modal manusia di seluruh wilayah Indonesia.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, meridai upaya kita dalam menyediakan informasi statistik yang berkualitas, sehingga IMM dapat menjadi instrumen yang andal dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Jakarta, Agustus 2026
Kepala Badan Pusat Statistik

Amalia Adininggar Widyasanti



Kata Pengantar

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pembangunan modal manusia merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia, serta akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa. Perencanaan pembangunan yang terarah dan berbasis data diperlukan untuk memastikan setiap intervensi pembangunan dapat memberikan dampak yang optimal terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan indikator yang terukur, metodologi yang baku, dan sumber data yang andal menjadi landasan penting untuk menghasilkan informasi pembangunan yang dapat dimanfaatkan dalam proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan.

Pada tahun 2025, Kementerian PPN/Bappenas mengembangkan Indeks Modal Manusia (IMM) sebagai instrumen untuk mengukur potensi produktivitas manusia secara lebih komprehensif berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu kelangsungan hidup (*survival*), pendidikan, dan kesehatan. Lebih lanjut, nilai IMM juga dapat didisagregasi di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tantangan dan kebutuhan pembangunan yang berbeda di setiap wilayah, dan menjadi dasar perumusan kebijakan yang sesuai untuk menjawab tantangan dan mengurangi kesenjangan pembangunan manusia antarwilayah.

Kami memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami bisa menyelesaikan penghitungan IMM tahun 2025 dan Buku Pedoman Penghitungan Indeks Modal Manusia yang akan menjadi pedoman dalam penghitungan dan pemanfaatan IMM di Indonesia. Pedoman ini menjadi acuan metodologi untuk memastikan penghitungan dan interpretasi IMM dilakukan secara terstandar, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan di berbagai tingkat pemerintahan. Selain menjelaskan capaian IMM, buku ini juga memandu berbagai strategi spesifik di bidang pendidikan dan kesehatan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Strategi tersebut diarahkan untuk memperkuat capaian pada masing-masing dimensi penyusun IMM. Melalui Buku Pedoman ini

diharapkan terbentuk kesamaan pemahaman dalam pemanfaatan IMM untuk mendukung perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan.

Besar harapan kami agar pengukuran IMM dapat terus diperkuat dan disempurnakan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas data, penajaman strategi spesifik sesuai kebutuhan kewilayahan, penguatan sinergi lintas sektor, serta penyempurnaan metodologi sehingga IMM semakin andal sebagai instrumen dalam mendukung perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan modal manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta, Agustus 2026

Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan

Pungkas Bahjuri Ali

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	i
Kata Sambutan Menteri PPN/Kepala Bappenas	iii
Kata Sambutan Kepala Badan Pusat Statistik	v
Kata Pengantar	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR ISTILAH	xii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang Pengembangan Indeks Modal Manusia dengan Konteks Indonesia	1
1.2. Tujuan dan Manfaat Buku Pedoman	3
BAB II Memahami Indeks Modal Manusia	5
2.1. Adaptasi HCI <i>World Bank</i> Menjadi IMM Indonesia	5
2.2. Metodologi Penghitungan IMM Indonesia	8
BAB III Hasil IMM Tahun 2025	15
3.1. Sumber Data Penghitungan IMM Tahun 2025	15
3.2. Gambaran Umum Capaian IMM Indonesia	16
3.3. Gambaran Umum Capaian IMM pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	19
BAB IV Pemanfaatan IMM dalam Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia	35
4.1. Integrasi IMM ke dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	35
4.2. Intervensi Peningkatan Indeks Modal Manusia	38
BAB V Penutup	49
5.1. <i>Disclaimer</i>	49
5.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	49
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkembangan Modal Manusia Sepanjang Tahap Kehidupan.....	2
Gambar 2. Diagram Penghitungan IMM.....	8
Gambar 3. Sebaran dan Disparitas Capaian IMM Kabupaten/Kota Tahun 2025 Menurut Provinsi	18
Gambar 4. Contoh Ilustrasi Analisis dan Pemanfaatan Hasil IMM.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Pendekatan Pengukuran Modal Manusia yang Pernah Diadopsi oleh Indonesia	5
Tabel 2. Perbandingan Indikator HCI <i>World Bank</i> dengan IMM	7
Tabel 3. Karakteristik Statistik Indikator Komponen IMM	8
Tabel 4. Sumber Data yang Digunakan dalam Penghitungan IMM Tahun 2025.....	15
Tabel 5. Capaian Setiap Indikator dan Dimensi IMM Nasional	17
Tabel 6. Capaian IMM Tahun 2025 dan Indikator Penyusunnya pada Level Provinsi dan Kabupaten/Kota.....	19
Tabel 7. Proses Integrasi IMM ke dalam Perencanaan Daerah.....	35
Tabel 8. Pembagian Tanggung Jawab Perangkat Daerah dalam Peningkatan IMM.....	38

DAFTAR ISTILAH

AKBA	: Angka Kematian Balita
AN	: Asesmen Nasional
ANC	: <i>Antenatal Care</i> (pelayanan kesehatan masa kehamilan)
ATS	: Anak Tidak Sekolah
ASR	: <i>Adult Survival Rate</i> (Angka Kelangsungan Hidup Dewasa 15-60 tahun)
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BPJS	: Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
BPS	: Badan Pusat Statistik
Dapodik	: Data Pokok Pendidikan (Kemendikdasmen)
EMIS	: <i>Education Management Information System</i> (Kemenag)
HCI	: <i>Human Capital Index</i> (IMM dalam konteks global)
HDI	: <i>Human Development Index</i> (IPM dalam konteks global)
HLS	: Harapan Lama Sekolah
HPK	: Hari Pertama Kehidupan
IMM	: Indeks Modal Manusia
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
LAYS	: <i>Learning-Adjusted Years of Schooling</i>
MBG	: Makan Bergizi Gratis
MRPN	: Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
MTBS	: Manajemen Terpadu Balita Sakit
PD	: Perangkat Daerah
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PISA	: <i>Programme for International Student Assessment</i>
PIRLS	: <i>Progress in International Reading Literacy Study</i>
PONED	: Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar
PONEK	: Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif
PTM	: Penyakit Tidak Menular
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SDM	: Sumber Daya Manusia
SLB	: Sekolah Luar Biasa
SP	: Sensus Penduduk
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SSGI	: Survei Status Gizi Indonesia
SUPAS	: Survei Penduduk Antar Sensus
SUSENAS	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
TIMSS	: <i>Trends in International Mathematics and Science Study</i>
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>



BAB I

Pendahuluan

**Pedoman Penghitungan Indeks Modal Manusia
dan Capaian Tahun 2025**



BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Pengembangan Indeks Modal Manusia dengan Konteks Indonesia

Setiap manusia memiliki hak dasar yang terdiri dari hak untuk hidup dan tumbuh, hak atas kesehatan, serta hak atas pendidikan yang bermutu, sebagaimana yang tercantum pada kerangka hukum kesepakatan internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (1948), *Convention on the Rights of the Child* (1989), serta *Sustainable Development Goals* (2015). Berdasarkan konsensus ini, setiap negara berupaya untuk memenuhi hak dasar tersebut melalui proses pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan SDM menghasilkan modal manusia yang membuat seorang individu mampu hidup produktif sepanjang hidupnya.

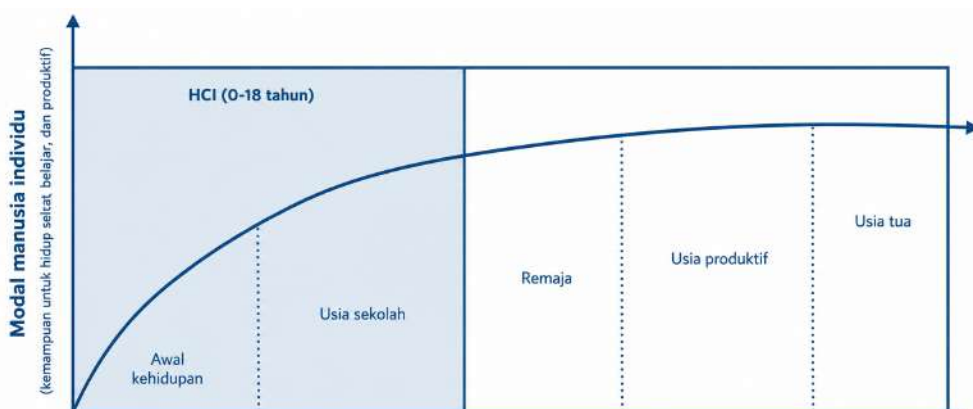
Di Indonesia, mandat atas pemenuhan hak dasar setiap warga negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dipertegas kembali dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Negara berkewajiban memastikan bahwa setiap anak yang lahir memiliki peluang yang sama untuk bertahan hidup, tumbuh sehat, memperoleh pendidikan yang berkualitas, dan berkembang secara optimal. Dengan demikian, pembangunan SDM tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen peningkatan kinerja ekonomi, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan dan kesejahteraan antargenerasi.

Pemenuhan hak dasar manusia bersifat kumulatif dan berlangsung sepanjang siklus hidup. Pada masa awal kehidupan, hak untuk hidup dan memperoleh layanan kesehatan ibu dan anak yang memadai menentukan peluang seorang anak untuk bertahan hidup dan tumbuh secara sehat. Memasuki usia anak dan remaja, hak atas pendidikan yang bermutu berperan penting dalam membentuk kemampuan kognitif, karakter, dan keterampilan dasar. Kegagalan dalam pemenuhan hak pada fase-fase awal ini akan membawa dampak jangka panjang yang sulit diperbaiki di tahap kehidupan berikutnya. Oleh karena itu, pembangunan manusia perlu dipandang

sebagai suatu proses berkelanjutan lintas sektor dan lintas tahap kehidupan, bukan sebagai serangkaian intervensi yang berdiri sendiri.

Gambar 1 menggambarkan proses akumulasi pemenuhan hak dasar manusia sepanjang siklus hidup. Fase awal kehidupan hingga usia 18 tahun merupakan periode penting dalam pembentukan kesehatan, kemampuan belajar, dan kapasitas individu. Pemenuhan hak dasar yang berkualitas pada masa ini akan meningkatkan kapasitas fisik dan kognitif seseorang hingga dewasa. Dalam jangka panjang, hal tersebut berkontribusi pada peningkatan kualitas modal manusia, produktivitas, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi, yang merupakan hasil dari kebijakan publik yang berhasil menjamin hak dasar secara berkelanjutan.

Gambar 1. Perkembangan Modal Manusia Sepanjang Tahap Kehidupan



Selama lebih dari tiga dekade, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah menjadi salah satu indikator penting dalam menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di Indonesia. Seiring berkembangnya tantangan pembangunan, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk menggambarkan kualitas sumber daya manusia yang dibentuk sepanjang siklus kehidupan. IMM disusun untuk melengkapi pengukuran IPM dengan melihat keterkaitan kelangsungan hidup, pendidikan, dan kesehatan terhadap produktivitas dalam satu siklus kehidupan. Dengan pendekatan ini, pembangunan manusia dapat dipahami secara lebih komprehensif sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa.

IMM Indonesia dikembangkan sebagai adaptasi nasional dari *Human Capital Index* (HCI)¹ *World Bank* dengan menyesuaikan konteks, sumber data, dan kebutuhan perencanaan pembangunan di Indonesia. IMM Indonesia mengukur tiga dimensi utama, yaitu kelangsungan hidup (*survival*), pendidikan (*education*), dan kesehatan (*health*), yang merepresentasikan hak-hak dasar dalam membentuk kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Melalui ketiga dimensi tersebut, IMM menilai potensi produktivitas individu di masa dewasa sebagai hasil akumulasi pemenuhan hak dasar selama masa tumbuh kembang.

Sejak 2025, IMM ditetapkan dalam RPJPN 2025–2045 sebagai salah satu indikator sasaran visi Indonesia Emas 2045 untuk peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. IMM berperan penting dalam mendukung pemanfaatan bonus demografi dan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 melalui pemantauan kualitas modal manusia sejak masa tumbuh kembang, identifikasi kesenjangan antarwilayah, serta penilaian risiko hilangnya potensi produktivitas generasi mendatang.

1.2. Tujuan dan Manfaat Buku Pedoman

Buku pedoman ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memahami konsep, metodologi, interpretasi, serta pemanfaatan hasil pengukuran IMM, termasuk capaian IMM tahun 2025. Pedoman ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai intervensi kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian setiap indikator penyusun IMM. Selain itu, pedoman ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengintegrasikan IMM ke dalam perencanaan pembangunan daerah, mengidentifikasi area yang masih memerlukan perhatian, serta merumuskan kebijakan, program, dan intervensi yang lebih tepat sasaran dalam rangka mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

¹ Dalam pedoman ini, istilah *Human Capital Index* (HCI) mengacu pada indeks yang dibentuk oleh *World Bank*, sedangkan istilah Indeks Modal Manusia (IMM) mengacu pada indeks yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai indikator nasional yang berlaku hingga tingkat kabupaten/kota.



BAB II

Memahami Indeks Modal Manusia

**Pedoman Penghitungan Indeks Modal Manusia
dan Capaian Tahun 2025**



BAB II

Memahami Indeks Modal Manusia

2.1. Adaptasi HCI *World Bank* Menjadi IMM Indonesia

Indonesia telah menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengacu pada *Human Development Index* (HDI) dari UNDP untuk mengukur capaian pembangunan manusia melalui aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. IPM bersifat deskriptif dan menggambarkan hasil pembangunan pada suatu periode. Untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih berorientasi masa depan, *World Bank* mengembangkan *Human Capital Index* (HCI) yang mengukur potensi produktivitas seseorang saat dewasa berdasarkan kualitas kesehatan dan pendidikan yang diterima sejak lahir. HCI menggunakan skala 0–1 untuk menunjukkan tingkat produktivitas yang dapat dicapai dibandingkan kondisi ideal. Mengacu pada konsep tersebut, Indonesia mengembangkan Indeks Modal Manusia (IMM) yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan nasional. IMM digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan sumber daya manusia, serta menyediakan informasi hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Tabel 1. Perbandingan Pendekatan Pengukuran Modal Manusia yang Pernah Diadopsi oleh Indonesia

Aspek Perbandingan	IPM	HCI / IMM
Pengembang Konsep	<i>United Nations Development Programme</i>	<i>World Bank</i>
Tujuan utama	Mengukur capaian pembangunan manusia saat ini	Mengukur potensi produktivitas sumber daya manusia di masa depan
Pertanyaan kebijakan utama	“Bagaimana kondisi pembangunan manusia saat ini?”	“Seberapa produktif generasi masa depan jika kondisi saat ini tidak berubah?”
Orientasi waktu	Retrospektif / kondisi saat ini	Prospektif / masa depan
Fokus kebijakan	Kesejahteraan dan kualitas hidup	Produktivitas, daya saing, dan investasi SDM
Pendekatan konseptual	<i>Outcome-based</i> (hasil yang dicapai)	<i>Investment-based</i> (hasil dari investasi kesehatan dan pendidikan)
Unit pengukuran	Indeks (0-100)	Indeks (0-1)
Dimensi utama	Kesehatan, pendidikan, standar hidup	Kelangsungan hidup (<i>survival</i>), pendidikan, kesehatan

Aspek Perbandingan	IPM	HCI / IMM
Kelebihan utama	Mudah digunakan untuk memantau capaian pembangunan manusia.	Mampu mengukur potensi produktivitas sumber daya manusia di masa depan sebagai dasar penetapan prioritas intervensi pembangunan modal manusia
Keterbatasan utama	Tidak mengukur potensi masa depan	Lebih kompleks dan bergantung pada asumsi serta ketersediaan data

Sumber: *United Nations Development Programme* (2020) dan *World Bank* (2018)

Apa itu Indeks Modal Manusia (IMM)?

Indeks Modal Manusia (IMM) adalah indeks yang mengukur potensi produktivitas individu pada usia produktif berdasarkan kondisi kesehatan dan pendidikan yang diperoleh selama masa tumbuh kembang. Pengukuran tersebut dilakukan melalui tiga dimensi utama, yaitu kelangsungan hidup (*survival*), pendidikan, dan kesehatan, yang merepresentasikan akumulasi modal manusia sejak awal kehidupan hingga memasuki usia produktif. Kemampuan seseorang untuk bekerja secara produktif tidak hanya ditentukan oleh tingkat pendidikan yang dicapai, tetapi juga oleh peluang untuk bertahan hidup pada masa kanak-kanak, kualitas pembelajaran yang diterima di sekolah, serta kondisi kesehatan yang memungkinkan perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Dengan demikian, IMM menggunakan pendekatan siklus hidup (*life-cycle approach*), yang memandang bahwa pemenuhan kebutuhan dasar pada setiap tahap kehidupan merupakan investasi yang menentukan kualitas modal manusia pada usia produktif. Kekurangan pada tahap awal kehidupan dapat berdampak jangka panjang dan sulit diperbaiki pada tahap berikutnya.

IMM dinyatakan dalam bentuk indeks positif dengan rentang nilai 0 hingga 1. Nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi potensi produktivitas yang dapat dicapai. Sebagai ilustrasi, nilai IMM Indonesia sebesar 0,562 pada tahun 2025, menunjukkan bahwa seorang anak yang lahir pada tahun tersebut diperkirakan hanya akan mencapai 56,2 persen dari potensi produktivitas maksimalnya ketika usia produktif berdasarkan kondisi kesehatan dan pendidikan yang diperoleh selama masa tumbuh kembang.

Indikator Penyusun IMM dengan Konteks Indonesia

Dalam proses adaptasi HCI *World Bank* menjadi IMM, dilakukan penyesuaian terhadap indikator penyusunnya agar sesuai dengan konteks pembangunan di Indonesia. Penyesuaian dilakukan agar indikator tersedia secara berkelanjutan, dapat dihitung hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta sesuai dengan sistem pendidikan dan kesehatan di Indonesia.

Penyesuaian hanya dilakukan pada dua indikator dalam dimensi pendidikan, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan *Harmonized Test Scores*. Pada indikator HLS, rentang usia pendidikan formal disesuaikan dari 4-17 tahun menjadi 4-18 tahun agar selaras dengan sistem pendidikan di Indonesia yang mencapai akhir jenjang pendidikan menengah pada usia 18 tahun. Sementara itu, pada indikator *Harmonized Test Scores*, HCI *World Bank* menggunakan skor asesmen pendidikan yang berlaku di tingkat internasional, seperti *Programme for International Student Assessment* (PISA), *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS), dan *Progress in International Reading Literacy Study* (PIRLS). Dalam IMM, indikator tersebut diadopsi menggunakan rata-rata nilai asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi. Adopsi tersebut dilakukan karena nilai asesmen nasional tersedia rutin setiap tahun dan dapat didisagregasi hingga tingkat kabupaten/kota. Selain itu, asesmen nasional disusun dengan kerangka konseptual yang selaras dengan asesmen tingkat internasional. Dengan penyesuaian tersebut, IMM tetap mempertahankan kerangka konseptual HCI *World Bank* (2018), dengan tetap relevan untuk mendukung perencanaan pembangunan sumber daya manusia di tingkat nasional dan daerah. Secara ringkas, perbandingan antara indikator HCI *World Bank* dan IMM disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Indikator HCI *World Bank* dengan IMM

Dimensi	Konsep	Indikator pada HCI <i>World Bank</i>	Penyesuaian dengan Konteks Indonesia	
			Indikator	Sumber Data
Kelangsungan hidup (<i>survival</i>)	Apakah anak yang lahir hari ini dapat bertahan hidup hingga usia sekolah?	Angka kelangsungan hidup balita	Angka kelangsungan hidup balita	Sensus Penduduk, SUPAS (BPS)
Pendidikan	Berapa lama masa sekolah yang dapat mereka tempuh?	Harapan Lama Sekolah rentang usia 4-17 tahun	Harapan Lama Sekolah rentang usia 4-18 tahun	• SUSENAS (BPS) • Dapodik (Kemendikdasmen) • EMIS (Kemenag) • Sensus Penduduk atau SUPAS (BPS)
	Berapa banyak yang dapat mereka pelajari?	<i>Harmonized test score</i> dari rata-rata nilai PISA/TIMSS/PIRLS	<i>Harmonized test score</i> dari rata-rata nilai asesmen tingkat nasional (literasi membaca dan numerasi)	Asesmen Nasional (Kemendikdasmen)

Dimensi	Konsep	Indikator pada HCI <i>World Bank</i>	Penyesuaian dengan Konteks Indonesia	
			Indikator	Sumber Data
Kesehatan	Apakah mereka dapat lulus dalam kondisi sehat serta siap untuk bekerja atau menempuh pendidikan lebih lanjut?	Proporsi balita bebas <i>stunting</i>	Proporsi balita bebas <i>stunting</i>	SSGI (Kemenkes)
		Angka kelangsungan hidup penduduk usia 15-60 tahun	Angka kelangsungan hidup penduduk usia 15-60 tahun	Sensus Penduduk, SUPAS (BPS)

2.2. Metodologi Penghitungan IMM Indonesia

IMM dibangun dari tiga dimensi utama, yaitu kelangsungan hidup (*survival*), pendidikan, dan kesehatan. Masing-masing dimensi dihitung menggunakan indikator yang merepresentasikan aspek penting dalam pembentukan modal manusia. Selanjutnya, nilai pada setiap dimensi dikombinasikan melalui rumus penghitungan IMM sehingga menghasilkan satu nilai indeks yang menggambarkan potensi produktivitas di masa depan. Untuk menghitung IMM, batas minimum dan maksimum untuk setiap indikator komponen IMM adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Karakteristik Statistik Indikator Komponen IMM

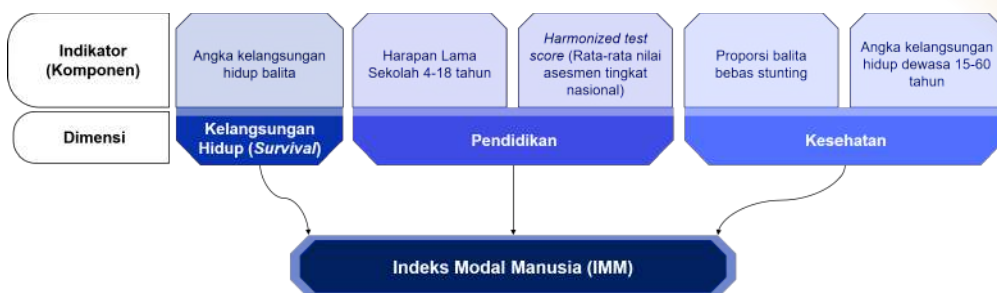
Indikator Komponen IMM	Satuan	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Sifat Indikator
Angka kelangsungan hidup balita	tanpa satuan	0	1	Positif
Harapan Lama Sekolah rentang usia 4-18 tahun	tahun	0	15	Positif
Rata-rata nilai asesmen tingkat nasional (literasi membaca dan numerasi)	tanpa satuan	0	100	Positif
Proporsi balita bebas <i>stunting</i>	tanpa satuan	0	1	Positif
Angka kelangsungan hidup penduduk usia 15-60 tahun	tanpa satuan	0	1	Positif

Keterangan: Sifat indikator positif, artinya semakin **mendekati nilai maksimum**, maka capaian semakin baik.

Nilai IMM dapat dihitung melalui formula penghitungan sebagai berikut:

$$IMM = Dimensi Survival \times Dimensi Pendidikan \times Dimensi Kesehatan$$

Gambar 2. Diagram Penghitungan IMM



2.2.1 Metode Penghitungan Dimensi Kelangsungan Hidup (Survival)

Dimensi kelangsungan hidup menggambarkan peluang seorang anak untuk bertahan hidup hingga usia lima tahun atau memasuki usia sekolah, yang diukur melalui indikator angka kelangsungan hidup balita. Dimensi ini menegaskan bahwa bertahannya anak hingga usia lima tahun memberikan kesempatan anak untuk dapat memperoleh pendidikan, tumbuh sehat, dan mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Secara operasional, dimensi kelangsungan hidup (*survival*) dihitung sebagai berikut:

$$\text{Dimensi kelangsungan hidup (survival)} = \text{Angka kelangsungan hidup balita}$$

Dimensi *survival* merupakan indeks positif yang bernilai 0 hingga 1. Nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan peluang seorang anak untuk bertahan hidup hingga usia lima tahun semakin tinggi. Sebaliknya, nilai yang rendah mencerminkan risiko kematian balita yang lebih besar dan secara tidak langsung mengindikasikan tingginya beban penyakit, kematian neonatal atau balita, serta keterbatasan layanan kesehatan dasar dan kondisi lingkungan yang belum mendukung tumbuh kembang anak sejak awal kehidupan.

Angka Kelangsungan Hidup Balita

Angka kelangsungan hidup balita adalah persentase balita yang bertahan hidup hingga usia lima tahun, yang dihitung dari kebalikan angka kematian balita.

$$\text{Angka kelangsungan hidup balita} = 1 - \text{Angka kematian balita}$$

Indikator ini bersifat positif dengan nilai antara 0 hingga 1. Nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan peluang seorang anak untuk bertahan hidup hingga usia lima tahun semakin tinggi. Angka kelangsungan hidup balita dihitung menggunakan

Sensus Penduduk dan SUPAS. Sensus Penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun memiliki cakupan responden yang sangat besar sehingga menghasilkan estimasi yang dapat dihitung hingga tingkat kabupaten/kota. Sementara itu, SUPAS dilaksanakan di antara periode sensus dengan cakupan sampel yang lebih kecil sehingga estimasinya umumnya memadai hingga tingkat provinsi.

2.2.2 Metode Penghitungan Dimensi Pendidikan

Dimensi pendidikan mengukur kesempatan seorang anak untuk memperoleh pembelajaran yang berkualitas selama menempuh pendidikan. Dimensi ini tidak hanya memperhitungkan lamanya seorang anak bersekolah, tetapi juga kualitas pembelajaran yang diterimanya. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa lamanya seseorang bersekolah tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kemampuan yang dikuasai.

Untuk mengukur dimensi pendidikan, IMM menggunakan *Learning-Adjusted Years of Schooling* (LAYS), yaitu lama sekolah yang telah disesuaikan dengan kualitas pembelajaran. LAYS dihitung menggunakan dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan *Harmonized Test Scores*. Dalam penghitungan tersebut, *Harmonized Test Scores* berfungsi menyesuaikan Harapan Lama Sekolah berdasarkan capaian hasil belajar, sehingga menghasilkan ukuran lama sekolah yang benar-benar mencerminkan pembelajaran yang berkualitas.

Sebagai ilustrasi, apabila Harapan Lama Sekolah mencapai 12 tahun, tetapi LAYS hanya 8 tahun, berarti meskipun seorang anak menghabiskan 12 tahun di bangku sekolah, hasil pembelajaran yang diperolehnya setara dengan sekitar 8 tahun pendidikan berkualitas. Dengan demikian, LAYS memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kontribusi pendidikan terhadap pembentukan modal manusia dibandingkan hanya menggunakan lama sekolah. Secara matematis, formula penghitungan dimensi pendidikan adalah sebagai berikut:

$$\text{Dimensi pendidikan} = e^{\emptyset(LAYS-15)}$$

dengan:

$$LAYS = \text{Harapan Lama Sekolah 4 – 18 tahun} \times \text{Harmonized Test Scores}$$

$\emptyset$ merupakan parameter imbal hasil pendidikan (*return to education*) sebesar 0,08, yang mengasumsikan setiap tambahan satu tahun pendidikan berkualitas berpotensi meningkatkan pendapatan sekitar 8 persen. Nilai ini mengacu pada pendekatan *World Bank* dalam penghitungan HCI (Kraay, 2018) dan didasarkan pada estimasi Montenegro dan Patrinos (2014). Nilai tersebut juga berada dalam rentang

estimasi empiris untuk Indonesia, yaitu 6,8–10,6 persen (Duflo, 2001), sehingga dinilai relevan untuk digunakan. Parameter ini akan ditinjau kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan estimasi *return to education* di Indonesia.

Dimensi pendidikan merupakan indeks positif dengan nilai antara 0 hingga 1, di mana nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan kontribusi pendidikan yang semakin besar terhadap potensi produktivitas individu di masa dewasa. Sebaliknya, nilai yang lebih rendah mencerminkan kondisi pendidikan yang belum optimal, baik karena rendahnya partisipasi sekolah maupun rendahnya capaian pembelajaran.

Harapan Lama Sekolah (HLS) 4-18 tahun

HLS 4-18 tahun adalah lamanya tahun sekolah yang diharapkan akan dijalani oleh seorang anak ketika berusia 4 sampai 18 tahun berdasarkan tingkat partisipasi sekolah pada tahun berjalan. Rumus penghitungan HLS penduduk usia 4-18 tahun adalah sebagai berikut:

$$HLS_{4-18}^t = FK \left(\sum_{i=4}^{18} \frac{E_i^t}{P_i^t} \right)$$

dengan:

$$FK = \frac{\text{Jumlah peserta didik usia 4 – 18 tahun yang menjalani pendidikan formal dengan bermukim}}{\text{Jumlah penduduk usia 4 – 18 tahun}} + 1$$

Keterangan:

FK = Faktor koreksi

E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t

i = Usia (4, 5, ... , 18)

HLS 4-18 tahun memiliki rentang nilai antara 0 hingga 15 tahun. HLS 4-18 tahun yang digunakan dalam IMM berbeda dengan HLS pada IPM. Dalam IMM, HLS dihitung untuk penduduk usia 4-18 tahun karena berfokus pada pembentukan modal manusia selama masa tumbuh kembang anak, yaitu sejak usia mulai mengikuti PAUD hingga sebelum memasuki usia dewasa. Sementara itu, HLS pada IPM dihitung untuk penduduk usia 7 tahun ke atas untuk menggambarkan ekspektasi lama pendidikan formal yang dapat dijalani seorang individu sepanjang hidup.

Dalam penghitungan HLS pada IMM, diterapkan faktor koreksi untuk mengakomodasi anak usia 4-18 tahun yang tidak tercakup dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), seperti peserta didik yang tinggal di pesantren atau sekolah berasrama. Faktor koreksi tersebut dihitung dengan membandingkan jumlah peserta didik usia 4-18 tahun yang menjalani pendidikan formal dengan bermukim berdasarkan data administrasi peserta didik dari Kemendikdasmen dan Kemenag, terhadap jumlah penduduk usia 4-18 tahun berdasarkan data proyeksi penduduk dari SP/SUPAS. Dengan demikian, nilai HLS yang dihasilkan lebih mencerminkan kondisi partisipasi sekolah yang sebenarnya.

Harmonized Test Score

Harmonized Test Score didekati menggunakan rata-rata nilai asesmen tingkat nasional pada kompetensi literasi membaca dan numerasi yang diperoleh dari Kemendikdasmen. Kedua kompetensi tersebut merupakan fondasi pembelajaran dan pengembangan modal manusia yang berpengaruh terhadap produktivitas pada usia kerja. Rumus perhitungan *Harmonized Test Score* pada IMM Indonesia adalah sebagai berikut:

$$\text{Harmonized Test Score} = \frac{\text{Rata - rata nilai asesmen tingkat nasional}}{\text{Nilai batas pencapaian tingkat lanjut}}$$

Dengan, rata-rata nilai asesmen tingkat nasional dihitung dari rata-rata nilai Asesmen Nasional untuk literasi membaca dan numerasi di seluruh jenjang pendidikan pada satuan pendidikan di bawah Kemendikdasmen dan Kemenag. Sementara, nilai batas pencapaian tingkat lanjut ditetapkan berdasarkan nilai batas pencapaian kategori kompetensi mahir (*advanced*) dalam AN, yaitu sebesar 84,5.

2.2.3 Metode Penghitungan Dimensi Kesehatan

Dimensi kesehatan menggambarkan kondisi kesehatan individu sejak awal kehidupan hingga usia produktif. Dimensi ini mencerminkan kondisi fisik dan kognitif yang memungkinkan seseorang tumbuh, belajar, dan bekerja secara produktif. Dimensi ini diukur menggunakan dua indikator, yaitu proporsi balita bebas *stunting* dan angka kelangsungan hidup dewasa usia 15-60 tahun. Formula penghitungan dimensi kesehatan adalah sebagai berikut:

$$\text{Dimensi kesehatan} = e^{\left(\frac{\gamma(ASR - 1) + \delta(\text{proporsi balita bebas stunting} - 1)}{2} \right)}$$

Keterangan:

ASR = angka kelangsungan hidup dewasa

γ = parameter kontribusi relatif tingkat kelangsungan hidup dewasa usia 15-60 tahun terhadap produktivitas, yaitu sebesar 0,65.

δ = parameter kontribusi relatif *stunting* terhadap produktivitas, yaitu sebesar 0,35.

Dimensi kesehatan merupakan indeks positif dengan nilai antara 0 hingga 1. Nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan kontribusi kesehatan yang semakin besar terhadap potensi produktivitas individu di usia dewasa. Nilai parameter γ dan δ menunjukkan bahwa angka kelangsungan hidup dewasa diberikan bobot yang lebih besar dibandingkan proporsi balita bebas *stunting*. Pembobotan dengan pertimbangan bahwa seseorang perlu bertahan hidup hingga usia produktif agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Sementara, proporsi balita bebas *stunting* berperan dalam menentukan kualitas kesehatan, kemampuan belajar, dan produktivitas pada usia dewasa. Kedua indikator tersebut saling melengkapi dalam menggambarkan kontribusi kesehatan terhadap pembentukan modal manusia.

Proporsi Balita Bebas *Stunting*

Proporsi balita bebas *stunting* menunjukkan proporsi balita yang tumbuh sesuai dengan standar usianya dan tidak mengalami *stunting*. Indikator ini merefleksikan kualitas pemenuhan gizi dan kesehatan pada masa awal kehidupan, yaitu periode kritis yang sangat menentukan perkembangan dan kondisi kesehatan jangka panjang anak. *Stunting* dapat berdampak menetap hingga dewasa, termasuk menurunkan kapasitas fisik dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit. Sebagai indikator positif, proporsi balita bebas *stunting* memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1, semakin tinggi proporsi balita yang tumbuh tanpa mengalami *stunting*. Secara matematis, indikator tersebut dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Proporsi balita bebas stunting} = 1 - \text{prevalensi stunting}$$

Prevalensi *stunting* dihitung berdasarkan data jumlah anak yang mengalami *stunting* yang diperoleh dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang diselenggarakan oleh Kemenkes.

Angka Kelangsungan Hidup Dewasa Usia 15-60 Tahun

Angka kelangsungan hidup dewasa usia 15-60 tahun mengukur probabilitas seorang individu yang berusia 15 tahun untuk bertahan hidup hingga usia 60 tahun.

Indikator ini mencerminkan kondisi kesehatan selama usia produktif, termasuk risiko kematian dini dan efektivitas layanan kesehatan. Angka kelangsungan hidup dewasa dihitung menggunakan data Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) serta merupakan indikator positif dengan nilai antara 0 hingga 1. Nilai yang semakin mendekati 1 mengindikasikan peluang yang lebih besar bagi individu untuk memasuki dan menjalani usia produktif secara optimal. Sebaliknya, nilai yang lebih rendah mencerminkan tingginya kehilangan potensi modal manusia akibat kematian prematur dan beban penyakit pada usia produktif. Secara operasional, tingkat kelangsungan hidup dewasa usia 15-60 tahun dirumuskan sebagai:

$$ASR = \frac{l_{60}}{l_{15}}$$

dengan:

ASR = tingkat kelangsungan hidup dewasa usia 15-60 tahun

l_{15} = jumlah penduduk yang bertahan hidup pada usia 15 tahun

l_{60} = jumlah penduduk yang bertahan hidup pada usia 60 tahun



BAB III

Hasil IMM Tahun 2025

**Pedoman Penghitungan Indeks Modal Manusia
dan Capaian Tahun 2025**



BAB III

Hasil IMM Tahun 2025

3.1. Sumber Data Penghitungan IMM Tahun 2025

Hasil perhitungan Indeks Modal Manusia (IMM) tahun 2025 merupakan *baseline* pertama pengukuran IMM. Penghitungan IMM menggunakan data statistik resmi dan data administrasi dari berbagai kementerian/lembaga. Sumber data yang digunakan dalam penghitungan IMM tahun 2025 dijelaskan pada Tabel 4.

Tabel 4. Sumber Data yang Digunakan dalam Penghitungan IMM Tahun 2025

Indikator Komponen IMM	Variabel Statistik yang Digunakan	Sumber dan Tahun Data	Nilai Nasional
Angka kelangsungan hidup balita	Angka kematian balita	Hasil Sementara SUPAS BPS (2025)	1,6 persen atau 0,016
Harapan Lama Sekolah rentang usia 4-18 tahun	Harapan Lama Sekolah rentang usia 4-18 tahun	1. Susenas BPS (2025) 2. Dapodik Kemendikdasmen (2025) 3. EMIS Kemenag (2025) 4. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan SP2020 dan dikoreksi dengan SUPAS BPS (2025)	12,82 tahun
Rata-rata nilai asesmen nasional	Rata-rata nilai asesmen nasional pada aspek literasi membaca dan numerasi	Asesmen Nasional Kemendikdasmen (2025)	58,07
Proporsi balita bebas <i>stunting</i>	Prevalensi <i>stunting</i>	SSGI Kemenkes (2024)	19,8 persen
Angka kelangsungan hidup penduduk usia 15-60 tahun	Angka kelangsungan hidup penduduk usia 15-60 tahun	Hasil Sementara SUPAS BPS (2025)	0,909

Keterangan:

- Sebagian indikator penyusun IMM berasal dari survei sampel sehingga tingkat presisi estimasinya dapat menurun pada tingkat kabupaten/kota.
- Capaian HLS 4-18 tahun di Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Puncak memiliki *Relative Standard Error* (RSE) di atas 25 persen, sehingga hasilnya perlu diinterpretasikan secara hati-hati dan dipertimbangkan bersama informasi pendukung lainnya dalam penyusunan kebijakan.
- Nilai IMM kabupaten/kota lebih tepat digunakan sebagai gambaran kondisi relatif dan dasar penentuan prioritas intervensi daripada sebagai peringkat yang bersifat presisi.

Hasil yang disajikan pada bab ini mencakup nilai IMM nasional, provinsi, dan kabupaten/kota beserta capaian pada setiap dimensi dan indikator penyusunnya. Penyajian hasil tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi modal manusia di Indonesia serta menjadi dasar dalam mengidentifikasi prioritas intervensi pembangunan manusia di tingkat nasional maupun daerah. Sebagai indeks yang dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan nasional, nilai IMM tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan *Human Capital Index* (HCI) *World Bank* karena metodologi penghitungannya telah disesuaikan dengan karakteristik dan ketersediaan data di Indonesia.

3.2. Gambaran Umum Capaian IMM Indonesia

Berdasarkan data yang tersedia pada Tabel 4, dilakukan penghitungan capaian indikator dan dimensi penyusun IMM tahun 2025 menggunakan formula penghitungan sebagai berikut.

Dimensi Kelangsungan Hidup (<i>Survival</i>)	$\begin{aligned} \text{Angka kelangsungan hidup balita} &= 1 - \text{Angka Kematian Balita} \\ &= 1 - 1,6\% \\ &= 0,984 \text{ atau } 98,4\% \end{aligned}$
Dimensi Pendidikan	$\begin{aligned} LAYS &= HLS\ 4 - 18 \text{ tahun} \times \text{Harmonized Test Scores} \\ &= HLS\ 4 - 18 \text{ tahun} \times \frac{\text{Rata - rata nilai asesmen nasional}}{\text{Nilai batas pencapaian tingkat lanjut}} \\ &= 12,82 \times \frac{58,07}{84,5} \\ &= 8,81 \text{ tahun} \end{aligned}$ sehingga, nilai dimensi pendidikan sebagai berikut: $\begin{aligned} e^{\emptyset(LAYS-15)} &= e^{0,08(8,81-15)} \\ &= 0,609 \end{aligned}$
Dimensi Kesehatan	$\begin{aligned} \text{Proporsi balita bebas stunting} &= 1 - \text{prevalensi stunting} \\ &= 1 - 19,8\% \\ &= 0,802 \end{aligned}$ sehingga, nilai dimensi kesehatan sebagai berikut: $\begin{aligned} &e^{\left(\frac{\gamma(ASR - 1) + \delta(\text{proporsi balita bebas stunting} - 1)}{2}\right)} \\ &\left(e^{\left(\frac{(0,65 \times (0,909 - 1)) + (0,35 \times (0,802 - 1))}{2}\right)}\right) = 0,938 \end{aligned}$

IMM	$\text{Dimensi survival} \times \text{Dimensi pendidikan} \times \text{Dimensi kesehatan}$ $= 0,984 \times 0,609 \times 0,938$ $= 0,562$
-----	--

Penerapan formula penghitungan tersebut menghasilkan capaian IMM tahun 2025 beserta capaian setiap dimensi dan indikator penyusunnya sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Capaian Setiap Indikator dan Dimensi IMM Nasional

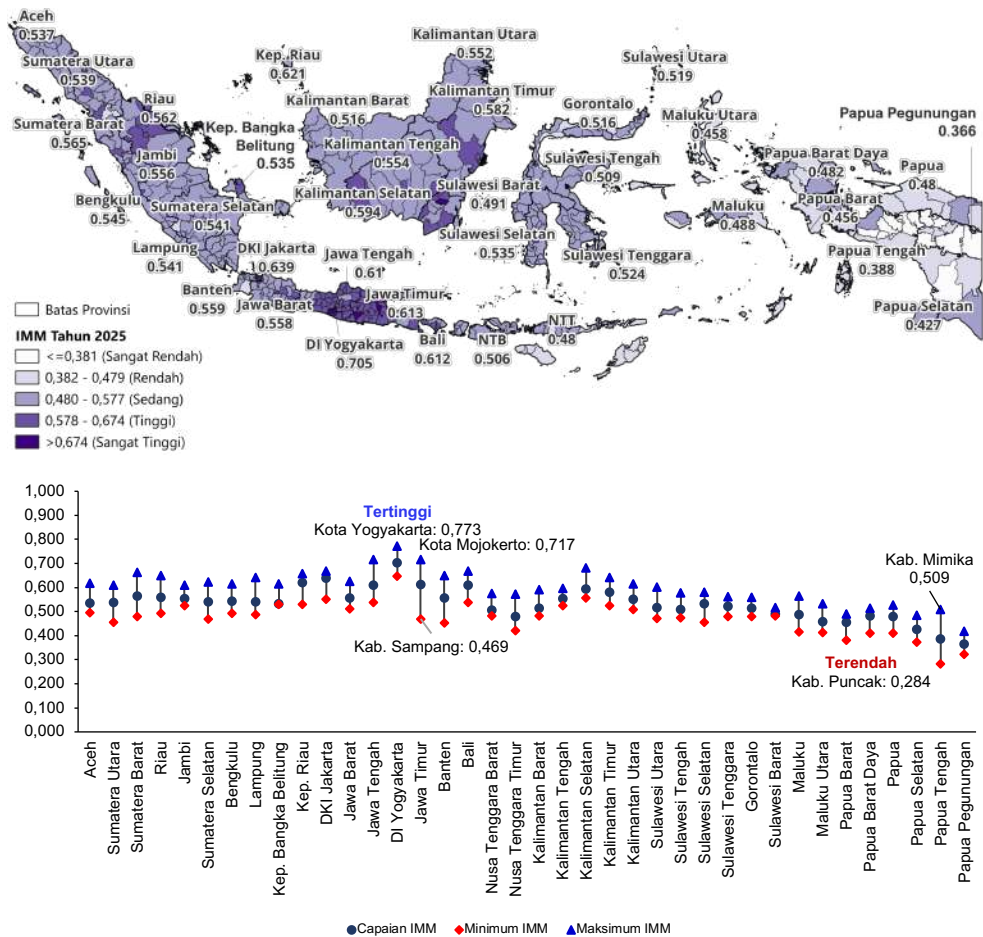
Indikator	Capaian
Dimensi Kelangsungan Hidup (<i>Survival</i>)	0,984
Angka Kelangsungan Hidup Balita	0,984
Dimensi Pendidikan	0,609
HLS 4-18 tahun	12,820
Rata-rata Nilai Asesmen Nasional	58,070
Dimensi Kesehatan	0,938
Proporsi Balita Bebas <i>Stunting</i>	0,802
Angka Kelangsungan Hidup Dewasa 15-60 tahun	0,909
IMM Indonesia Tahun 2025	0,562

Penjelasan Nilai IMM

Angka IMM Indonesia tahun 2025 sebesar 0,562, yang berarti seorang anak yang lahir pada tahun 2025 diperkirakan hanya akan mencapai 56,2 persen dari potensi produktivitas maksimalnya ketika usia produktif berdasarkan kondisi kesehatan dan pendidikan yang diperoleh selama masa tumbuh kembang. Nilai tersebut merupakan estimasi dengan asumsi bahwa kondisi layanan pendidikan dan kesehatan yang dihadapi anak selama masa tumbuh kembang tidak mengalami perubahan yang signifikan. Potensi produktivitas maksimal didefinisikan sebagai kondisi ideal ketika seluruh anak bertahan hidup hingga usia sekolah, menempuh 15 tahun pendidikan dengan capaian pembelajaran pada kategori mahir (*advanced*), tumbuh tanpa mengalami *stunting*, serta memiliki peluang bertahan hidup hingga usia produktif yang optimal.

Sebaran Capaian IMM Berdasarkan Wilayah

Gambar 3. Sebaran dan Disparitas Capaian IMM Kabupaten/Kota Tahun 2025 Menurut Provinsi



Keterangan: Pengkategorian pada peta spasial di atas bersifat relatif terhadap sebaran tahun 2025 sebagai *baseline* sehingga batas antarkategori akan ditinjau kembali pada rilis berikutnya. Pengkategorian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi daerah yang memerlukan prioritas intervensi, bukan sebagai penilaian baik atau buruk.

Gambar 3 menunjukkan bahwa nilai IMM kabupaten/kota di Indonesia masih bervariasi, baik antarprovinsi maupun di dalam provinsi. Secara umum, kabupaten/kota di wilayah Indonesia bagian barat cenderung memiliki nilai IMM yang lebih tinggi dibandingkan sebagian wilayah Indonesia bagian timur. Selain itu, provinsi dengan rentang nilai yang lebar mengindikasikan kesenjangan pembangunan modal manusia antarkabupaten/kota yang relatif besar, sedangkan rentang yang sempit

menunjukkan kondisi yang lebih merata. Oleh karena itu, hasil IMM perlu dibaca tidak hanya berdasarkan nilai rata-rata provinsi, tetapi juga dengan memperhatikan variasi capaian antarkabupaten/kota sebagai dasar penentuan prioritas intervensi pembangunan manusia, khususnya di wilayah yang masih tertinggal.

3.3. Gambaran Umum Capaian IMM pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Capaian IMM tahun 2025 beserta nilai masing-masing indikator penyusunnya pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang disajikan pada Tabel 6 memberikan gambaran mengenai kondisi pembangunan modal manusia di setiap daerah. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi prioritas intervensi sesuai dengan dimensi dan indikator yang masih memerlukan perhatian.

Tabel 6. Capaian IMM Tahun 2025 dan Indikator Penyusunnya pada Level Provinsi dan Kabupaten/Kota

Wilayah	Angka Kelangsungan Hidup Balita	Dimensi Survival	HLS 4-18	Rata-rata skor AN	Dimensi Pendidikan	Proporsi Balita Bebas Stunting	Angka Kelangsungan Hidup Dewasa (15-60 tahun)	Dimensi Kesehatan	IMM 2025
Prov. Aceh	0,979	0,979	13,280	54,28	0,596	0,714	0,901	0,921	0,537
Simeulue	0,962	0,962	13,216	55,16	0,601	0,745	0,880	0,920	0,532
Aceh Singkil	0,964	0,964	13,514	50,98	0,578	0,658	0,856	0,899	0,501
Aceh Selatan	0,968	0,968	13,830	54,09	0,612	0,658	0,871	0,903	0,535
Aceh Tenggara	0,977	0,977	13,154	50,34	0,564	0,691	0,843	0,900	0,496
Aceh Timur	0,975	0,975	12,504	52,30	0,559	0,633	0,910	0,911	0,497
Aceh Tengah	0,979	0,979	13,067	55,58	0,599	0,686	0,893	0,914	0,536
Aceh Barat	0,973	0,973	13,794	50,90	0,586	0,744	0,920	0,932	0,531
Aceh Besar	0,978	0,978	13,190	57,02	0,614	0,677	0,913	0,919	0,552
Pidie	0,964	0,964	12,814	55,66	0,592	0,674	0,920	0,920	0,525
Bireun	0,980	0,980	13,853	56,74	0,634	0,729	0,899	0,923	0,574
Aceh Utara	0,977	0,977	13,509	50,10	0,572	0,808	0,896	0,935	0,522
Aceh Barat Daya	0,967	0,967	13,085	52,03	0,574	0,638	0,912	0,912	0,506
Gayo Lues	0,964	0,964	12,838	54,06	0,581	0,794	0,881	0,928	0,520
Aceh Tamiang	0,981	0,981	13,138	55,42	0,600	0,726	0,896	0,922	0,543
Nagan Raya	0,976	0,976	13,063	51,36	0,568	0,645	0,926	0,917	0,509
Aceh Jaya	0,970	0,970	13,841	58,11	0,645	0,690	0,909	0,920	0,575
Bener Meriah	0,977	0,977	13,341	52,84	0,587	0,672	0,919	0,920	0,528
Pidie Jaya	0,978	0,978	13,978	54,03	0,616	0,684	0,916	0,921	0,555
Kota Banda Aceh	0,986	0,986	13,248	63,63	0,669	0,763	0,930	0,938	0,619
Kota Sabang	0,980	0,980	13,198	62,36	0,657	0,766	0,941	0,942	0,606

Wilayah	Angka Kelangsungan Hidup Balita	Dimensi Survival	HLS 4-18	Rata-rata skor AN	Dimensi Pendidikan	Proporsi Balita Bebas Stunting	Angka Kelangsungan Hidup Dewasa (15-60 tahun)	Dimensi Kesehatan	IMM 2025
Kota Langsa	0,983	0,983	13,301	57,26	0,619	0,844	0,909	0,945	0,575
Kota Lhokseumawe	0,986	0,986	13,334	58,39	0,629	0,792	0,887	0,930	0,577
Kota Subulussalam	0,963	0,963	12,963	52,33	0,572	0,725	0,845	0,906	0,499
Prov. Sumatera Utara	0,980	0,980	12,752	55,72	0,590	0,780	0,901	0,932	0,539
Nias	0,973	0,973	12,460	57,34	0,592	0,739	0,875	0,917	0,529
Mandailing Natal	0,972	0,972	14,116	55,20	0,630	0,778	0,846	0,915	0,560
Tapanuli Selatan	0,973	0,973	13,442	58,18	0,632	0,934	0,891	0,954	0,586
Tapanuli Tengah	0,973	0,973	12,468	52,74	0,561	0,677	0,851	0,900	0,492
Tapanuli Utara	0,981	0,981	12,406	57,21	0,590	0,675	0,895	0,913	0,528
Toba Samosir	0,981	0,981	12,634	61,74	0,630	0,729	0,898	0,923	0,571
Labuhan Batu	0,976	0,976	12,567	53,52	0,569	0,747	0,880	0,920	0,511
Asahan	0,979	0,979	12,446	54,53	0,573	0,861	0,899	0,945	0,529
Simalungun	0,980	0,980	12,544	54,60	0,576	0,740	0,890	0,922	0,521
Dairi	0,981	0,981	12,844	59,67	0,622	0,710	0,983	0,945	0,577
Karo	0,982	0,982	12,510	59,06	0,606	0,824	0,912	0,942	0,561
Deli Serdang	0,980	0,980	12,714	56,18	0,592	0,804	0,904	0,937	0,543
Langkat	0,981	0,981	12,827	51,19	0,561	0,840	0,889	0,938	0,516
Nias Selatan	0,971	0,971	12,720	47,41	0,533	0,624	0,827	0,885	0,458
Humbang Hasundutan	0,981	0,981	12,470	61,64	0,624	0,817	0,908	0,940	0,575
Pakpak Bharat	0,974	0,974	12,778	59,43	0,618	0,725	0,907	0,925	0,557
Samosir	0,981	0,981	12,699	63,74	0,648	0,714	0,917	0,926	0,588
Serdang Bedagai	0,978	0,978	12,564	53,32	0,568	0,810	0,899	0,936	0,520
Batu Bara	0,975	0,975	11,981	51,44	0,540	0,770	0,904	0,931	0,490
Padang Lawas Utara	0,971	0,971	12,727	46,36	0,527	0,700	0,903	0,919	0,470
Padang Lawas	0,972	0,972	12,761	50,86	0,557	0,748	0,922	0,933	0,505
Labuhan Batu Selatan	0,974	0,974	12,921	53,07	0,576	0,780	0,904	0,933	0,524
Labuhan Batu Utara	0,981	0,981	12,867	52,42	0,570	0,825	0,887	0,935	0,523
Nias Utara	0,975	0,975	12,844	56,66	0,600	0,742	0,853	0,911	0,533
Nias Barat	0,974	0,974	13,516	59,31	0,643	0,656	0,848	0,896	0,561
Kota Sibolga	0,980	0,980	12,404	67,13	0,663	0,819	0,909	0,941	0,610
Kota Tanjung Balai	0,979	0,979	12,436	52,97	0,562	0,944	0,859	0,946	0,521
Kota Pematang Siantar	0,982	0,982	12,899	62,40	0,645	0,878	0,916	0,953	0,604
Kota Tebing Tinggi	0,982	0,982	12,604	59,68	0,614	0,824	0,898	0,938	0,566
Kota Medan	0,984	0,984	12,871	61,08	0,634	0,846	0,933	0,952	0,594

Wilayah	Angka Kelangsungan Hidup Balita	Dimensi Survival	HLS 4-18	Rata-rata skor AN	Dimensi Pendidikan	Proporsi Balita Bebas Stunting	Angka Kelangsungan Hidup Dewasa (15-60 tahun)	Dimensi Kesehatan	IMM 2025
Kota Binjai	0,983	0,983	12,719	59,54	0,617	0,744	0,907	0,928	0,563
Kota Padangsidempuan	0,980	0,980	12,993	58,83	0,621	0,697	0,909	0,921	0,560
Kota Gunungsitoli	0,981	0,981	12,813	57,94	0,608	0,826	0,882	0,933	0,557
Prov. Sumatera Barat	0,982	0,982	13,013	58,76	0,621	0,751	0,898	0,926	0,565
Kepulauan Mentawai	0,969	0,969	12,723	49,01	0,544	0,738	0,858	0,912	0,480
Pesisir Selatan	0,979	0,979	12,514	52,19	0,559	0,735	0,884	0,919	0,503
Solok	0,973	0,973	12,778	59,73	0,620	0,705	0,885	0,915	0,552
Sijunjung	0,974	0,974	12,528	57,20	0,594	0,718	0,884	0,917	0,530
Tanah Datar	0,981	0,981	12,846	61,19	0,634	0,731	0,901	0,924	0,575
Padang Pariaman	0,981	0,981	13,466	56,97	0,623	0,734	0,901	0,924	0,565
Agam	0,983	0,983	13,149	62,36	0,655	0,730	0,889	0,920	0,592
Lima Puluh Kota	0,979	0,979	12,973	58,85	0,621	0,734	0,923	0,931	0,565
Pasaman	0,971	0,971	13,043	58,81	0,623	0,709	0,889	0,917	0,554
Solok Selatan	0,972	0,972	12,590	57,71	0,599	0,785	0,895	0,931	0,542
Dharmasraya	0,980	0,980	13,093	57,48	0,614	0,795	0,895	0,932	0,561
Pasaman Barat	0,974	0,974	12,682	54,51	0,580	0,734	0,895	0,923	0,521
Kota Padang	0,987	0,987	13,172	62,19	0,654	0,794	0,903	0,935	0,603
Kota Solok	0,984	0,984	13,485	62,09	0,665	0,814	0,891	0,934	0,612
Kota Sawah Lunto	0,978	0,978	13,316	64,10	0,676	0,800	0,916	0,939	0,621
Kota Padang Panjang	0,983	0,983	13,093	68,78	0,706	0,810	0,942	0,949	0,659
Kota Bukittinggi	0,988	0,988	13,601	67,22	0,716	0,832	0,900	0,940	0,665
Kota Payakumbuh	0,984	0,984	13,557	63,95	0,684	0,836	0,923	0,948	0,638
Kota Pariaman	0,982	0,982	13,225	59,47	0,634	0,843	0,906	0,944	0,588
Prov. Riau	0,983	0,983	12,809	58,35	0,611	0,799	0,901	0,935	0,562
Kuantan Singingi	0,979	0,979	13,028	57,26	0,610	0,769	0,903	0,931	0,556
Indragiri Hulu	0,979	0,979	12,617	56,64	0,592	0,800	0,891	0,932	0,540
Indragiri Hilir	0,978	0,978	11,469	55,15	0,548	0,750	0,877	0,920	0,493
Pelalawan	0,984	0,984	12,547	59,21	0,609	0,832	0,889	0,937	0,561
Siak	0,979	0,979	13,132	59,54	0,631	0,838	0,911	0,944	0,584
Kampar	0,980	0,980	13,325	58,04	0,626	0,838	0,904	0,942	0,578
Rokan Hulu	0,987	0,987	12,520	56,31	0,587	0,786	0,911	0,936	0,542
Bengkalis	0,982	0,982	13,208	59,65	0,635	0,875	0,893	0,945	0,589
Rokan Hilir	0,979	0,979	12,491	53,66	0,568	0,755	0,905	0,929	0,517
Kepulauan Meranti	0,976	0,976	12,698	56,95	0,597	0,820	0,856	0,925	0,539
Kota Pekanbaru	0,988	0,988	13,358	65,98	0,694	0,855	0,922	0,950	0,651
Kota Dumai	0,985	0,985	12,942	62,61	0,649	0,831	0,887	0,936	0,598

Wilayah	Angka Kelangsungan Hidup Balita	Dimensi Survival	HLS 4-18	Rata-rata skor AN	Dimensi Pendidikan	Proporsi Balita Bebas Stunting	Angka Kelangsungan Hidup Dewasa (15-60 tahun)	Dimensi Kesehatan	IMM 2025
Prov. Jambi	0,982	0,982	13,002	56,34	0,603	0,829	0,900	0,940	0,556
Kerinci	0,979	0,979	12,923	57,13	0,606	0,836	0,928	0,949	0,563
Merangin	0,983	0,983	13,906	52,46	0,601	0,904	0,888	0,948	0,560
Sarolangun	0,979	0,979	12,816	56,34	0,597	0,934	0,898	0,956	0,559
Batang Hari	0,984	0,984	13,236	55,98	0,607	0,816	0,905	0,939	0,561
Muaro Jambi	0,985	0,985	13,223	56,24	0,609	0,812	0,886	0,933	0,559
Tanjung Jabung Timur	0,982	0,982	12,419	58,05	0,596	0,761	0,893	0,926	0,542
Tanjung Jabung Barat	0,978	0,978	12,476	55,51	0,580	0,930	0,880	0,950	0,539
Tebo	0,980	0,980	12,534	55,03	0,579	0,758	0,905	0,929	0,527
Bungo	0,981	0,981	12,729	56,08	0,592	0,796	0,886	0,930	0,540
Kota Jambi	0,987	0,987	13,356	60,39	0,646	0,897	0,927	0,959	0,612
Kota Sungai Penuh	0,982	0,982	13,278	59,51	0,636	0,920	0,900	0,954	0,597
Prov. Sumatera Selatan	0,982	0,982	12,557	55,89	0,585	0,842	0,898	0,941	0,541
Ogan Komering Ulu	0,979	0,979	12,690	54,63	0,581	0,780	0,907	0,934	0,531
Ogan Komering Ilir	0,982	0,982	11,471	54,17	0,542	0,757	0,877	0,921	0,490
Muara Enim	0,983	0,983	12,484	55,01	0,577	0,796	0,901	0,934	0,530
Lahat	0,979	0,979	13,010	53,12	0,579	0,871	0,924	0,954	0,541
Musi Rawas	0,981	0,981	13,033	54,72	0,592	0,807	0,887	0,932	0,541
Musi Banyuasin	0,982	0,982	12,712	56,08	0,592	0,852	0,882	0,938	0,545
Banyuasin	0,983	0,983	11,902	54,45	0,556	0,832	0,877	0,933	0,510
Ogan Komering Ulu Selatan	0,979	0,979	12,531	49,59	0,542	0,834	0,876	0,933	0,496
Ogan Komering Ulu Timur	0,983	0,983	12,951	58,41	0,616	0,826	0,925	0,947	0,574
Ogan Ilir	0,977	0,977	12,148	53,56	0,558	0,726	0,884	0,918	0,500
Empat Lawang	0,968	0,968	12,252	49,56	0,535	0,681	0,880	0,909	0,471
Penukal Abab Lematang Ilir	0,981	0,981	12,530	54,39	0,574	0,795	0,891	0,931	0,524
Musi Rawas Utara	0,977	0,977	12,366	51,62	0,551	0,780	0,853	0,917	0,494
Kota Palembang	0,986	0,986	13,078	63,57	0,662	0,894	0,922	0,957	0,624
Kota Prabumulih	0,984	0,984	12,628	59,74	0,615	0,884	0,899	0,948	0,574
Kota Pagar Alam	0,979	0,979	12,553	56,14	0,587	0,800	0,909	0,938	0,539
Kota Lubuklinggau	0,984	0,984	12,633	57,12	0,596	0,791	0,901	0,934	0,548
Prov. Bengkulu	0,979	0,979	12,782	56,06	0,594	0,812	0,902	0,937	0,545
Bengkulu Selatan	0,978	0,978	12,773	56,75	0,598	0,817	0,912	0,941	0,551
Rejang Lebong	0,982	0,982	12,221	56,61	0,580	0,753	0,886	0,923	0,526
Bengkulu Utara	0,977	0,977	12,475	56,82	0,589	0,793	0,908	0,936	0,539

Wilayah	Angka Kelangsungan Hidup Balita	Dimensi Survival	HLS 4-18	Rata-rata skor AN	Dimensi Pendidikan	Proporsi Balita Bebas Stunting	Angka Kelangsungan Hidup Dewasa (15-60 tahun)	Dimensi Kesehatan	IMM 2025
Kaur	0,976	0,976	13,451	51,64	0,581	0,841	0,901	0,942	0,534
Seluma	0,977	0,977	13,060	53,28	0,582	0,774	0,900	0,930	0,529
Mukomuko	0,981	0,981	12,956	55,65	0,596	0,780	0,899	0,931	0,544
Lebong	0,975	0,975	12,054	52,67	0,549	0,773	0,871	0,922	0,494
Kepahiang	0,976	0,976	12,255	56,12	0,578	0,830	0,890	0,937	0,528
Bengkulu Tengah	0,978	0,978	11,897	54,70	0,558	0,766	0,903	0,930	0,507
Kota Bengkulu	0,984	0,984	13,634	60,96	0,662	0,839	0,921	0,948	0,617
Prov. Lampung	0,982	0,982	12,630	55,68	0,586	0,841	0,892	0,939	0,541
Lampung Barat	0,981	0,981	12,846	56,64	0,600	0,795	0,890	0,931	0,548
Tanggamus	0,981	0,981	11,866	52,48	0,543	0,751	0,871	0,918	0,489
Lampung Selatan	0,983	0,983	12,588	55,36	0,583	0,896	0,882	0,945	0,541
Lampung Timur	0,982	0,982	12,748	55,30	0,587	0,860	0,905	0,946	0,545
Lampung Tengah	0,982	0,982	12,541	54,96	0,578	0,845	0,894	0,940	0,534
Lampung Utara	0,982	0,982	12,644	53,41	0,571	0,800	0,888	0,931	0,522
Way Kanan	0,983	0,983	12,551	54,35	0,575	0,861	0,909	0,947	0,535
Tulang Bawang	0,981	0,981	12,773	56,34	0,595	0,817	0,898	0,937	0,547
Pesawaran	0,981	0,981	11,875	52,64	0,544	0,845	0,885	0,938	0,501
Pringsewu	0,984	0,984	12,918	58,36	0,615	0,805	0,894	0,934	0,565
Mesuji	0,981	0,981	12,690	55,46	0,586	0,889	0,886	0,945	0,544
Tulang Bawang Barat	0,982	0,982	12,505	52,70	0,562	0,866	0,906	0,947	0,523
Pesisir Barat	0,981	0,981	12,739	57,07	0,599	0,802	0,853	0,921	0,542
Kota Bandar Lampung	0,984	0,984	12,815	62,46	0,643	0,852	0,886	0,939	0,594
Kota Metro	0,987	0,987	13,607	63,37	0,681	0,852	0,934	0,954	0,642
Prov. Kep. Bangka Belitung	0,982	0,982	12,522	55,87	0,584	0,799	0,894	0,933	0,535
Bangka	0,983	0,983	12,713	61,36	0,630	0,788	0,912	0,936	0,580
Belitung	0,981	0,981	12,254	61,23	0,613	0,819	0,917	0,943	0,567
Bangka Barat	0,980	0,980	12,310	57,62	0,589	0,801	0,868	0,925	0,535
Bangka Tengah	0,981	0,981	12,859	60,21	0,627	0,788	0,853	0,919	0,565
Bangka Selatan	0,978	0,978	12,177	58,74	0,593	0,754	0,862	0,916	0,531
Belitung Timur	0,980	0,980	12,175	59,39	0,597	0,829	0,902	0,940	0,550
Kota Pangkal Pinang	0,987	0,987	12,996	63,53	0,658	0,827	0,938	0,951	0,618
Prov. Kep. Riau	0,985	0,985	13,280	62,97	0,665	0,850	0,918	0,948	0,621
Karimun	0,984	0,984	12,935	59,26	0,622	0,786	0,885	0,928	0,569
Bintan	0,986	0,986	13,628	60,33	0,656	0,837	0,893	0,939	0,607
Natuna	0,982	0,982	13,332	55,67	0,608	0,815	0,897	0,936	0,559
Lingga	0,981	0,981	12,530	55,68	0,583	0,802	0,872	0,926	0,530

Wilayah	Angka Kelangsungan Hidup Balita	Dimensi Survival	HLS 4-18	Rata-rata skor AN	Dimensi Pendidikan	Proporsi Balita Bebas Stunting	Angka Kelangsungan Hidup Dewasa (15-60 tahun)	Dimensi Kesehatan	IMM 2025
Kepulauan Anambas	0,982	0,982	12,909	58,76	0,618	0,842	0,894	0,940	0,570
Kota Batam	0,989	0,989	13,323	66,75	0,699	0,860	0,929	0,953	0,659
Kota Tanjung Pinang	0,988	0,988	13,545	65,23	0,695	0,871	0,915	0,951	0,653
Prov. DKI Jakarta	0,988	0,988	12,786	67,89	0,685	0,828	0,914	0,944	0,639
Kepulauan Seribu	0,985	0,985	13,040	54,54	0,591	0,831	0,937	0,951	0,553
Jakarta Selatan	0,989	0,989	13,155	69,32	0,714	0,851	0,919	0,949	0,671
Jakarta Timur	0,987	0,987	12,809	68,69	0,693	0,836	0,922	0,947	0,648
Jakarta Pusat	0,990	0,990	12,721	68,06	0,684	0,797	0,903	0,935	0,633
Jakarta Barat	0,989	0,989	12,740	66,73	0,674	0,826	0,912	0,943	0,628
Jakarta Utara	0,987	0,987	12,452	66,69	0,661	0,803	0,905	0,937	0,611
Prov. Jawa Barat	0,985	0,985	12,422	59,14	0,604	0,841	0,889	0,938	0,558
Bogor	0,984	0,984	12,003	58,16	0,583	0,811	0,868	0,927	0,532
Sukabumi	0,984	0,984	11,875	55,70	0,563	0,795	0,875	0,926	0,513
Cianjur	0,984	0,984	11,943	55,02	0,561	0,928	0,870	0,947	0,523
Bandung	0,985	0,985	12,417	59,97	0,610	0,759	0,864	0,917	0,551
Garut	0,984	0,984	12,355	56,85	0,586	0,858	0,883	0,939	0,541
Tasikmalaya	0,984	0,984	12,406	60,01	0,609	0,830	0,901	0,940	0,564
Ciamis	0,985	0,985	13,050	62,09	0,649	0,797	0,918	0,940	0,600
Kuningan	0,985	0,985	12,921	62,38	0,646	0,773	0,886	0,926	0,589
Cirebon	0,984	0,984	12,733	57,18	0,600	0,820	0,860	0,926	0,547
Majalengka	0,985	0,985	12,988	57,66	0,612	0,820	0,894	0,936	0,564
Sumedang	0,986	0,986	12,658	62,68	0,638	0,830	0,891	0,937	0,590
Indramayu	0,986	0,986	12,621	52,36	0,563	0,902	0,895	0,950	0,528
Subang	0,985	0,985	12,731	55,69	0,589	0,876	0,890	0,944	0,548
Purwakarta	0,987	0,987	12,386	58,75	0,600	0,856	0,906	0,946	0,560
Karawang	0,987	0,987	12,272	56,25	0,579	0,824	0,896	0,937	0,535
Bekasi	0,987	0,987	12,812	59,41	0,619	0,818	0,894	0,936	0,572
Bandung Barat	0,985	0,985	11,921	58,56	0,583	0,692	0,871	0,909	0,522
Pangandaran	0,986	0,986	12,827	58,67	0,614	0,827	0,939	0,951	0,576
Kota Bogor	0,987	0,987	12,308	63,11	0,628	0,789	0,896	0,932	0,578
Kota Sukabumi	0,985	0,985	12,570	61,92	0,629	0,803	0,866	0,925	0,573
Kota Bandung	0,989	0,989	12,640	68,00	0,680	0,772	0,887	0,926	0,622
Kota Cirebon	0,986	0,986	13,017	64,27	0,665	0,851	0,905	0,944	0,619
Kota Bekasi	0,989	0,989	12,351	67,35	0,662	0,883	0,928	0,957	0,626
Kota Depok	0,988	0,988	12,675	65,59	0,662	0,875	0,925	0,955	0,624
Kota Cimahi	0,987	0,987	12,527	65,04	0,651	0,777	0,908	0,933	0,600
Kota Tasikmalaya	0,986	0,986	12,602	62,10	0,632	0,804	0,889	0,932	0,581

Wilayah	Angka Kelangsungan Hidup Balita	Dimensi <i>Survival</i>	HLS 4-18	Rata-rata skor AN	Dimensi Pendidikan	Proporsi Balita Bebas <i>Stunting</i>	Angka Kelangsungan Hidup Dewasa (15-60 tahun)	Dimensi Kesehatan	IMM 2025
Kota Banjar	0,985	0,985	12,599	61,38	0,626	0,812	0,904	0,938	0,578
Prov. Jawa Tengah	0,986	0,986	13,224	62,19	0,656	0,830	0,912	0,943	0,610
Cilacap	0,985	0,985	12,901	62,27	0,644	0,844	0,898	0,941	0,598
Banyumas	0,984	0,984	13,171	62,29	0,655	0,804	0,915	0,940	0,606
Purbalingga	0,984	0,984	13,004	62,13	0,647	0,777	0,891	0,928	0,591
Banjarnegara	0,985	0,985	12,747	61,36	0,632	0,794	0,887	0,930	0,578
Kebumen	0,987	0,987	13,216	62,60	0,659	0,820	0,957	0,955	0,622
Purworejo	0,987	0,987	13,635	64,58	0,693	0,851	0,940	0,955	0,654
Wonosobo	0,983	0,983	13,450	65,13	0,690	0,761	0,896	0,927	0,629
Magelang	0,984	0,984	13,370	63,38	0,672	0,807	0,905	0,937	0,620
Boyolali	0,988	0,988	13,306	63,62	0,671	0,755	0,925	0,935	0,620
Klaten	0,987	0,987	13,776	64,08	0,695	0,792	0,919	0,939	0,644
Sukoharjo	0,988	0,988	13,995	64,40	0,707	0,832	0,934	0,950	0,664
Wonogiri	0,987	0,987	13,058	66,90	0,689	0,849	0,917	0,948	0,645
Karanganyar	0,987	0,987	13,729	62,43	0,678	0,826	0,922	0,946	0,633
Sragen	0,987	0,987	13,422	60,79	0,652	0,842	0,918	0,947	0,609
Grobogan	0,985	0,985	12,894	60,10	0,627	0,744	0,912	0,929	0,574
Blora	0,983	0,983	13,533	60,95	0,658	0,783	0,923	0,939	0,607
Rembang	0,984	0,984	13,485	61,92	0,664	0,842	0,914	0,946	0,618
Pati	0,986	0,986	13,818	65,01	0,705	0,835	0,922	0,947	0,659
Kudus	0,986	0,986	13,499	64,97	0,691	0,868	0,916	0,951	0,648
Jepara	0,987	0,987	13,103	61,83	0,649	0,844	0,913	0,946	0,605
Demak	0,986	0,986	13,052	61,09	0,641	0,900	0,913	0,955	0,603
Semarang	0,985	0,985	13,362	64,16	0,678	0,855	0,916	0,949	0,634
Temanggung	0,986	0,986	13,266	62,35	0,659	0,727	0,906	0,924	0,601
Kendal	0,985	0,985	13,362	60,54	0,648	0,808	0,909	0,939	0,599
Batang	0,987	0,987	13,198	61,38	0,649	0,793	0,908	0,936	0,599
Pekalongan	0,983	0,983	13,356	59,92	0,643	0,805	0,906	0,937	0,592
Pemalang	0,982	0,982	12,288	57,48	0,588	0,809	0,892	0,934	0,539
Tegal	0,983	0,983	12,563	57,65	0,598	0,841	0,874	0,934	0,548
Brebes	0,982	0,982	12,841	56,12	0,596	0,769	0,884	0,925	0,541
Kota Magelang	0,988	0,988	13,652	71,96	0,763	0,847	0,926	0,951	0,717
Kota Surakarta	0,988	0,988	14,031	69,98	0,763	0,838	0,926	0,949	0,715
Kota Salatiga	0,988	0,988	13,448	69,66	0,731	0,860	0,935	0,956	0,690
Kota Semarang	0,988	0,988	13,473	66,82	0,706	0,888	0,923	0,957	0,668
Kota Pekalongan	0,984	0,984	13,441	62,75	0,669	0,807	0,926	0,944	0,622
Kota Tegal	0,987	0,987	12,393	63,87	0,637	0,820	0,898	0,937	0,589

Wilayah	Angka Kelangsungan Hidup Balita	Dimensi <i>Survival</i>	HLS 4-18	Rata-rata skor AN	Dimensi Pendidikan	Proporsi Balita Bebas <i>Stunting</i>	Angka Kelangsungan Hidup Dewasa (15-60 tahun)	Dimensi Kesehatan	IMM 2025
Prov. DI Yogyakarta	0,988	0,988	14,039	68,99	0,754	0,826	0,926	0,947	0,705
Kulon Progo	0,989	0,989	13,784	66,88	0,721	0,820	0,929	0,947	0,675
Bantul	0,988	0,988	14,258	69,53	0,770	0,835	0,925	0,948	0,721
Gunung Kidul	0,987	0,987	13,852	64,35	0,700	0,803	0,903	0,936	0,647
Sleman	0,988	0,988	13,954	70,38	0,763	0,827	0,938	0,951	0,717
Kota Yogyakarta	0,989	0,989	14,156	74,90	0,822	0,852	0,926	0,951	0,773
Prov. Jawa Timur	0,986	0,986	13,447	61,18	0,656	0,853	0,914	0,948	0,613
Pacitan	0,985	0,985	13,160	63,31	0,663	0,883	0,931	0,958	0,625
Ponorogo	0,986	0,986	14,523	66,18	0,748	0,866	0,934	0,956	0,705
Trenggalek	0,986	0,986	13,353	64,16	0,678	0,933	0,908	0,959	0,641
Tulungagung	0,986	0,986	13,280	63,34	0,668	0,864	0,937	0,957	0,630
Blitar	0,986	0,986	13,735	66,11	0,712	0,822	0,901	0,939	0,659
Kediri	0,985	0,985	13,914	62,16	0,683	0,921	0,918	0,960	0,646
Malang	0,986	0,986	13,328	63,12	0,668	0,767	0,906	0,931	0,613
Lumajang	0,984	0,984	12,871	61,41	0,637	0,766	0,905	0,931	0,583
Jember	0,983	0,983	12,819	57,37	0,604	0,696	0,897	0,917	0,544
Banyuwangi	0,981	0,981	13,581	62,32	0,671	0,824	0,921	0,945	0,622
Bondowoso	0,979	0,979	13,219	55,70	0,605	0,888	0,895	0,948	0,561
Situbondo	0,978	0,978	12,754	55,93	0,592	0,894	0,896	0,949	0,549
Probolinggo	0,981	0,981	13,326	56,64	0,615	0,737	0,895	0,923	0,557
Pasuruan	0,983	0,983	13,409	60,50	0,649	0,739	0,882	0,919	0,586
Sidoarjo	0,988	0,988	13,482	67,26	0,711	0,894	0,932	0,960	0,674
Mojokerto	0,985	0,985	13,893	66,12	0,719	0,848	0,936	0,954	0,675
Jombang	0,984	0,984	13,589	62,34	0,672	0,828	0,927	0,948	0,626
Nganjuk	0,984	0,984	13,558	62,89	0,675	0,772	0,924	0,937	0,623
Madiun	0,985	0,985	13,714	66,45	0,714	0,879	0,918	0,953	0,670
Magetan	0,987	0,987	13,669	64,78	0,697	0,897	0,936	0,962	0,661
Ngawi	0,986	0,986	13,470	61,43	0,659	0,886	0,911	0,952	0,619
Bojonegoro	0,985	0,985	13,656	62,94	0,680	0,880	0,913	0,952	0,637
Tuban	0,985	0,985	13,593	59,15	0,645	0,887	0,928	0,958	0,608
Lamongan	0,985	0,985	13,497	62,67	0,671	0,931	0,927	0,965	0,638
Gresik	0,983	0,983	13,840	64,48	0,701	0,848	0,929	0,952	0,656
Bangkalan	0,979	0,979	13,051	52,53	0,576	0,824	0,866	0,928	0,524
Sampang	0,980	0,980	11,915	46,72	0,510	0,811	0,908	0,939	0,469
Pamekasan	0,979	0,979	13,068	50,93	0,566	0,777	0,893	0,929	0,514
Sumenep	0,980	0,980	13,359	49,95	0,567	0,888	0,900	0,949	0,527
Kota Kediri	0,988	0,988	14,067	66,02	0,726	0,824	0,928	0,947	0,679

Wilayah	Angka Kelangsungan Hidup Balita	Dimensi Survival	HLS 4-18	Rata-rata skor AN	Dimensi Pendidikan	Proporsi Balita Bebas Stunting	Angka Kelangsungan Hidup Dewasa (15-60 tahun)	Dimensi Kesehatan	IMM 2025
Kota Blitar	0,987	0,987	14,041	69,52	0,759	0,886	0,920	0,955	0,715
Kota Malang	0,988	0,988	13,622	71,25	0,755	0,772	0,926	0,938	0,699
Kota Probolinggo	0,982	0,982	13,430	62,14	0,664	0,769	0,910	0,933	0,608
Kota Pasuruan	0,985	0,985	13,991	64,27	0,706	0,817	0,916	0,942	0,655
Kota Mojokerto	0,988	0,988	14,099	69,04	0,757	0,883	0,933	0,958	0,717
kota Madiun	0,987	0,987	13,755	67,62	0,727	0,882	0,953	0,965	0,692
Kota Surabaya	0,988	0,988	13,590	67,15	0,715	0,915	0,919	0,960	0,678
Kota Batu	0,986	0,986	13,643	68,73	0,732	0,755	0,939	0,939	0,678
Prov. Banten	0,984	0,984	12,357	60,32	0,610	0,789	0,891	0,930	0,559
Pandeglang	0,979	0,979	12,200	52,34	0,551	0,736	0,843	0,907	0,490
Lebak	0,979	0,979	11,522	49,76	0,518	0,676	0,827	0,893	0,453
Tangerang	0,986	0,986	12,387	56,00	0,581	0,766	0,887	0,925	0,530
Serang	0,983	0,983	12,400	49,91	0,541	0,798	0,899	0,934	0,497
Kota Tangerang	0,987	0,987	12,513	65,34	0,653	0,888	0,917	0,955	0,616
Kota Cilegon	0,985	0,985	12,706	60,21	0,621	0,810	0,932	0,946	0,579
Kota Serang	0,986	0,986	12,027	56,10	0,571	0,771	0,885	0,926	0,521
Kota Tangerang Selatan	0,989	0,989	12,953	67,19	0,687	0,895	0,923	0,958	0,650
Prov. Bali	0,986	0,986	13,321	61,00	0,650	0,914	0,905	0,955	0,612
Jembrana	0,985	0,985	13,304	62,60	0,663	0,925	0,894	0,954	0,623
Tabanan	0,987	0,987	13,357	64,09	0,677	0,925	0,913	0,959	0,641
Badung	0,988	0,988	13,655	62,56	0,676	0,928	0,932	0,966	0,645
Gianyar	0,988	0,988	13,418	60,65	0,651	0,946	0,923	0,966	0,621
Klungkung	0,984	0,984	13,683	61,62	0,669	0,948	0,903	0,960	0,632
Bangli	0,981	0,981	12,494	56,66	0,589	0,917	0,898	0,954	0,551
Karang Asem	0,980	0,980	12,538	56,27	0,587	0,870	0,873	0,938	0,540
Buleleng	0,985	0,985	13,234	57,17	0,616	0,852	0,871	0,934	0,567
Kota Denpasar	0,989	0,989	13,488	66,94	0,708	0,896	0,914	0,955	0,668
Prov. Nusa Tenggara Barat	0,973	0,973	12,995	52,07	0,572	0,702	0,874	0,911	0,506
Lombok Barat	0,973	0,973	12,920	52,49	0,572	0,727	0,856	0,910	0,507
Lombok Tengah	0,968	0,968	12,604	49,86	0,546	0,751	0,854	0,913	0,482
Lombok Timur	0,970	0,970	12,918	51,78	0,567	0,670	0,889	0,911	0,501
Sumbawa	0,973	0,973	12,563	56,11	0,587	0,702	0,882	0,913	0,522
Dompu	0,969	0,969	13,005	49,20	0,552	0,802	0,882	0,930	0,497
Bima	0,971	0,971	12,998	51,53	0,568	0,762	0,850	0,914	0,504
Sumbawa Barat	0,973	0,973	14,100	54,98	0,627	0,818	0,895	0,936	0,572
Lombok Utara	0,968	0,968	13,438	48,49	0,558	0,647	0,881	0,904	0,489
Kota Mataram	0,984	0,984	13,401	58,69	0,634	0,765	0,883	0,924	0,577

Wilayah	Angka Kelangsungan Hidup Balita	Dimensi Survival	HLS 4-18	Rata-rata skor AN	Dimensi Pendidikan	Proporsi Balita Bebas Stunting	Angka Kelangsungan Hidup Dewasa (15-60 tahun)	Dimensi Kesehatan	IMM 2025
Kota Bima	0,978	0,978	13,782	53,66	0,607	0,716	0,924	0,928	0,551
Prov. Nusa Tenggara Timur	0,972	0,972	12,462	52,00	0,556	0,630	0,832	0,888	0,480
Sumba Barat	0,970	0,970	12,464	48,26	0,532	0,648	0,804	0,882	0,456
Sumba Timur	0,972	0,972	12,237	48,83	0,530	0,691	0,802	0,888	0,458
Kupang	0,959	0,959	12,142	53,30	0,556	0,605	0,819	0,880	0,469
Timor Tengah Selatan	0,970	0,970	12,086	49,47	0,530	0,432	0,832	0,857	0,441
Timor Tengah Utara	0,967	0,967	12,331	50,25	0,542	0,527	0,844	0,875	0,458
Belu	0,980	0,980	12,270	50,90	0,544	0,557	0,820	0,873	0,466
Alor	0,953	0,953	12,219	46,69	0,517	0,626	0,829	0,886	0,437
Lembata	0,977	0,977	13,350	57,20	0,621	0,743	0,822	0,902	0,547
Flores Timur	0,971	0,971	13,575	55,52	0,615	0,687	0,812	0,890	0,532
Sikka	0,978	0,978	11,597	52,87	0,538	0,677	0,839	0,897	0,472
Ende	0,970	0,970	12,617	57,79	0,601	0,693	0,854	0,904	0,527
Ngada	0,983	0,983	13,097	59,02	0,626	0,711	0,841	0,903	0,556
Manggarai	0,975	0,975	12,436	55,03	0,576	0,590	0,821	0,878	0,493
Rote Ndao	0,954	0,954	12,516	52,28	0,560	0,676	0,827	0,893	0,477
Manggarai Barat	0,976	0,976	12,879	53,20	0,576	0,689	0,839	0,899	0,505
Sumba Tengah	0,975	0,975	12,440	52,89	0,562	0,626	0,787	0,874	0,478
Sumba Barat Daya	0,957	0,957	12,862	44,23	0,516	0,525	0,778	0,856	0,423
Nagekeo	0,976	0,976	13,037	60,18	0,633	0,750	0,792	0,895	0,553
Manggarai Timur	0,976	0,976	11,902	49,80	0,528	0,612	0,844	0,888	0,458
Sabu Raijua	0,949	0,949	12,329	49,74	0,538	0,678	0,877	0,908	0,464
Malaka	0,982	0,982	11,803	45,66	0,502	0,684	0,805	0,888	0,438
Kota Kupang	0,984	0,984	12,968	59,99	0,629	0,731	0,908	0,926	0,573
Prov. Kalimantan Barat	0,981	0,981	12,234	55,26	0,571	0,732	0,888	0,920	0,516
Sambas	0,982	0,982	12,262	55,82	0,576	0,636	0,867	0,899	0,508
Bengkayang	0,982	0,982	12,042	53,01	0,551	0,766	0,899	0,929	0,503
Landak	0,980	0,980	12,410	53,25	0,563	0,714	0,885	0,916	0,506
Mempawah	0,982	0,982	12,321	52,11	0,553	0,714	0,868	0,911	0,495
Sanggau	0,984	0,984	11,847	54,74	0,557	0,787	0,893	0,930	0,510
Ketapang	0,981	0,981	12,349	54,59	0,570	0,821	0,893	0,936	0,524
Sintang	0,982	0,982	11,752	55,96	0,561	0,690	0,885	0,912	0,503
Kapuas Hulu	0,980	0,980	12,103	54,31	0,561	0,764	0,899	0,928	0,511
Sekadau	0,981	0,981	12,397	53,26	0,563	0,856	0,868	0,934	0,516
Melawi	0,981	0,981	11,984	52,52	0,547	0,648	0,876	0,903	0,484
Kayong Utara	0,975	0,975	12,870	53,81	0,580	0,762	0,890	0,926	0,523

Wilayah	Angka Kelangsungan Hidup Balita	Dimensi Survival	HLS 4-18	Rata-rata skor AN	Dimensi Pendidikan	Proporsi Balita Bebas Stunting	Angka Kelangsungan Hidup Dewasa (15-60 tahun)	Dimensi Kesehatan	IMM 2025
Kubu Raya	0,979	0,979	12,006	54,76	0,561	0,698	0,878	0,911	0,501
Kota Pontianak	0,986	0,986	12,880	61,90	0,641	0,777	0,916	0,936	0,591
Kota Singkawang	0,984	0,984	12,295	61,68	0,618	0,781	0,895	0,930	0,565
Prov. Kalimantan Tengah	0,980	0,980	12,880	57,69	0,609	0,779	0,893	0,929	0,554
Kotawaringin Barat	0,979	0,979	13,285	60,80	0,647	0,835	0,877	0,934	0,591
Kotawaringin Timur	0,984	0,984	11,921	60,61	0,597	0,784	0,863	0,921	0,541
Kapuas	0,976	0,976	12,727	54,44	0,580	0,775	0,885	0,926	0,525
Barito Selatan	0,976	0,976	13,081	56,37	0,605	0,667	0,889	0,910	0,538
Barito Utara	0,980	0,980	12,660	55,31	0,584	0,796	0,905	0,936	0,536
Sukamara	0,983	0,983	12,838	58,76	0,615	0,800	0,901	0,935	0,566
Lamandau	0,980	0,980	13,540	57,76	0,632	0,817	0,915	0,942	0,583
Seruyan	0,979	0,979	12,622	60,25	0,619	0,678	0,891	0,912	0,553
Katingan	0,982	0,982	13,101	54,95	0,595	0,804	0,894	0,934	0,546
Pulang Pisau	0,978	0,978	13,240	57,40	0,618	0,721	0,899	0,921	0,557
Gunung Mas	0,980	0,980	13,199	52,68	0,582	0,859	0,882	0,939	0,535
Barito Timur	0,974	0,974	13,818	58,07	0,644	0,783	0,930	0,941	0,590
Murung Raya	0,979	0,979	13,012	56,23	0,602	0,842	0,868	0,932	0,549
Kota Palangka Raya	0,984	0,984	13,178	60,25	0,639	0,809	0,946	0,950	0,597
Prov. Kalimantan Selatan	0,982	0,982	13,543	59,82	0,649	0,771	0,910	0,933	0,594
Tanah Laut	0,983	0,983	14,207	58,73	0,664	0,775	0,903	0,931	0,608
Kota Baru	0,981	0,981	13,388	56,93	0,620	0,768	0,890	0,926	0,563
Banjarnegara	0,978	0,978	12,876	59,58	0,623	0,677	0,911	0,918	0,559
Barito Kuala	0,974	0,974	13,649	58,60	0,642	0,835	0,903	0,941	0,589
Tapin	0,985	0,985	12,749	58,16	0,608	0,868	0,899	0,945	0,566
Hulu Sungai Selatan	0,974	0,974	13,282	58,02	0,625	0,802	0,928	0,944	0,574
Hulu Sungai Tengah	0,974	0,974	14,229	67,25	0,745	0,804	0,914	0,940	0,682
Hulu Sungai Utara	0,973	0,973	14,656	56,89	0,663	0,724	0,918	0,928	0,599
Tabalong	0,985	0,985	13,269	59,56	0,636	0,769	0,911	0,933	0,585
Tanah Bumbu	0,983	0,983	13,402	58,47	0,632	0,783	0,902	0,932	0,580
Balangan	0,980	0,980	14,116	56,36	0,640	0,840	0,940	0,954	0,598
Kota Banjarmasin	0,985	0,985	13,402	62,72	0,668	0,735	0,910	0,927	0,610
Kota Banjar Baru	0,986	0,986	13,854	65,91	0,715	0,846	0,927	0,951	0,670
Prov. Kalimantan Timur	0,983	0,983	12,920	60,86	0,634	0,777	0,912	0,935	0,582
Paser	0,981	0,981	12,743	60,11	0,622	0,766	0,895	0,928	0,566
Kutai Barat	0,981	0,981	13,285	55,99	0,609	0,724	0,882	0,917	0,548

Wilayah	Angka Kelangsungan Hidup Balita	Dimensi Survival	HLS 4-18	Rata-rata skor AN	Dimensi Pendidikan	Proporsi Balita Bebas Stunting	Angka Kelangsungan Hidup Dewasa (15-60 tahun)	Dimensi Kesehatan	IMM 2025
Kutai Kartanegara	0,983	0,983	13,074	59,67	0,630	0,857	0,909	0,947	0,587
Kutai Timur	0,983	0,983	13,332	58,91	0,634	0,731	0,899	0,923	0,575
Berau	0,979	0,979	12,779	56,72	0,598	0,766	0,900	0,929	0,544
Penajam Paser Utara	0,982	0,982	12,742	60,97	0,628	0,680	0,910	0,918	0,567
Mahakam Ulu	0,979	0,979	14,005	49,52	0,581	0,768	0,889	0,926	0,527
Kota Balikpapan	0,986	0,986	12,676	65,40	0,660	0,752	0,928	0,935	0,609
Kota Samarinda	0,985	0,985	12,538	64,28	0,646	0,797	0,922	0,941	0,599
Kota Bontang	0,984	0,984	13,573	65,28	0,697	0,793	0,918	0,939	0,644
Prov. Kalimantan Utara	0,982	0,982	12,756	57,34	0,602	0,824	0,885	0,934	0,552
Malinau	0,980	0,980	12,874	51,90	0,567	0,740	0,874	0,917	0,510
Bulungan	0,982	0,982	12,551	58,95	0,607	0,841	0,879	0,935	0,557
Tana Tidung	0,982	0,982	12,363	59,12	0,602	0,926	0,905	0,957	0,566
Nunukan	0,980	0,980	12,200	54,12	0,563	0,783	0,880	0,926	0,511
Kota Tarakan	0,985	0,985	13,295	62,62	0,662	0,874	0,892	0,945	0,616
Prov. Sulawesi Utara	0,982	0,982	12,630	53,14	0,569	0,792	0,887	0,930	0,519
Bolaang Mongondow	0,974	0,974	12,346	49,30	0,536	0,807	0,885	0,931	0,486
Minahasa	0,985	0,985	12,973	55,16	0,593	0,806	0,909	0,939	0,548
Kepulauan Sangihe (Sangihe Talaud)	0,983	0,983	12,842	54,42	0,584	0,758	0,902	0,928	0,533
Kepulauan Talaud	0,978	0,978	12,933	54,46	0,587	0,884	0,893	0,946	0,543
Minahasa Selatan	0,983	0,983	12,362	52,14	0,554	0,719	0,881	0,916	0,499
Minahasa Utara	0,984	0,984	12,525	51,58	0,555	0,811	0,900	0,936	0,512
Bolaang Mongondow Utara	0,980	0,980	12,472	49,48	0,540	0,737	0,824	0,902	0,478
Siau Tagulandang Biaro	0,982	0,982	12,952	49,99	0,556	0,801	0,908	0,937	0,512
Minahasa Tenggara	0,979	0,979	12,579	51,58	0,557	0,781	0,873	0,924	0,503
Bolaang Mongondow Selatan	0,971	0,971	12,543	48,17	0,534	0,764	0,841	0,911	0,472
Bolaang Mongondow Timur	0,979	0,979	12,164	47,90	0,523	0,812	0,872	0,928	0,475
Kota Manado	0,986	0,986	12,511	57,04	0,592	0,812	0,885	0,932	0,544
Kota Bitung	0,983	0,983	12,558	53,90	0,572	0,749	0,871	0,918	0,516
Kota Tomohon	0,986	0,986	13,025	60,79	0,637	0,892	0,929	0,959	0,603
Kota Kotamobagu	0,984	0,984	12,859	54,25	0,583	0,769	0,877	0,923	0,529
Prov. Sulawesi Tengah	0,968	0,968	12,812	53,22	0,574	0,739	0,868	0,915	0,509

Wilayah	Angka Kelangsungan Hidup Balita	Dimensi <i>Survival</i>	HLS 4-18	Rata-rata skor AN	Dimensi Pendidikan	Proporsi Balita Bebas <i>Stunting</i>	Angka Kelangsungan Hidup Dewasa (15-60 tahun)	Dimensi Kesehatan	IMM 2025
Banggai Kepulauan	0,953	0,953	13,368	54,05	0,597	0,716	0,865	0,911	0,518
Banggai	0,975	0,975	12,749	53,35	0,573	0,713	0,846	0,905	0,506
Morowali	0,972	0,972	13,707	56,29	0,625	0,774	0,883	0,925	0,562
Poso	0,980	0,980	12,926	53,77	0,582	0,789	0,887	0,929	0,529
Donggala	0,967	0,967	12,417	51,39	0,551	0,704	0,877	0,912	0,486
Toli-Toli	0,968	0,968	12,455	52,23	0,558	0,731	0,876	0,916	0,494
Buol	0,969	0,969	12,542	51,25	0,554	0,631	0,845	0,891	0,478
Parigi Moutong	0,960	0,960	12,477	49,76	0,542	0,777	0,847	0,915	0,476
Tojo Una-Una	0,966	0,966	12,473	51,75	0,555	0,835	0,820	0,916	0,491
Sigi	0,970	0,970	13,030	50,82	0,564	0,670	0,860	0,902	0,493
Banggai Laut	0,966	0,966	13,082	54,44	0,591	0,734	0,873	0,916	0,523
Morowali Utara	0,976	0,976	12,703	58,45	0,608	0,796	0,881	0,928	0,551
Kota Palu	0,982	0,982	13,182	59,66	0,634	0,744	0,913	0,929	0,579
Prov. Sulawesi Selatan	0,981	0,981	12,724	55,23	0,586	0,768	0,904	0,931	0,535
Kepulauan Selayar	0,979	0,979	13,047	54,05	0,587	0,743	0,881	0,920	0,529
Bulukumba	0,981	0,981	12,969	53,72	0,583	0,748	0,916	0,931	0,532
Bantaeng	0,976	0,976	12,799	50,71	0,557	0,757	0,952	0,943	0,513
Jeneponto	0,981	0,981	12,103	46,72	0,514	0,630	0,896	0,906	0,458
Takalar	0,979	0,979	13,107	56,62	0,608	0,760	0,909	0,931	0,554
Gowa	0,983	0,983	12,303	55,32	0,574	0,830	0,927	0,948	0,535
Sinjai	0,978	0,978	12,809	60,04	0,624	0,714	0,893	0,919	0,560
Maros	0,982	0,982	12,338	53,58	0,563	0,776	0,893	0,929	0,514
Pangkajene dan Kepulauan	0,978	0,978	12,382	53,22	0,562	0,748	0,902	0,927	0,509
Barru	0,977	0,977	13,032	56,14	0,602	0,731	0,913	0,927	0,546
Bone	0,979	0,979	12,504	54,72	0,576	0,740	0,888	0,921	0,519
Soppeng	0,979	0,979	13,431	59,63	0,643	0,734	0,897	0,923	0,581
Wajo	0,980	0,980	12,269	54,75	0,569	0,795	0,896	0,933	0,520
Sidenreng Rappang	0,984	0,984	12,457	55,92	0,582	0,797	0,911	0,938	0,537
Pinrang	0,984	0,984	12,598	52,70	0,565	0,778	0,918	0,937	0,520
Enrekang	0,982	0,982	13,601	57,80	0,634	0,657	0,908	0,914	0,569
Luwu	0,979	0,979	12,501	54,02	0,571	0,764	0,887	0,925	0,517
Tana Toraja	0,986	0,986	12,976	56,92	0,606	0,725	0,883	0,917	0,548
Luwu Utara	0,980	0,980	12,777	53,28	0,574	0,764	0,888	0,925	0,520
Luwu Timur	0,984	0,984	12,516	56,66	0,589	0,782	0,899	0,932	0,540
Toraja Utara	0,986	0,986	13,192	55,05	0,599	0,724	0,867	0,913	0,539
Kota Makassar	0,988	0,988	12,779	59,34	0,617	0,771	0,906	0,932	0,568

Wilayah	Angka Kelangsungan Hidup Balita	Dimensi Survival	HLS 4-18	Rata-rata skor AN	Dimensi Pendidikan	Proporsi Balita Bebas Stunting	Angka Kelangsungan Hidup Dewasa (15-60 tahun)	Dimensi Kesehatan	IMM 2025
Kota Parepare	0,986	0,986	12,883	58,30	0,613	0,739	0,897	0,924	0,559
Kota Palopo	0,982	0,982	13,042	57,23	0,611	0,773	0,923	0,937	0,562
Prov. Sulawesi Tenggara	0,975	0,975	12,918	53,84	0,582	0,739	0,898	0,924	0,524
Buton	0,968	0,968	13,577	56,00	0,619	0,712	0,899	0,920	0,551
Muna	0,973	0,973	13,006	59,15	0,624	0,750	0,902	0,927	0,563
Konawe	0,978	0,978	12,862	51,08	0,561	0,750	0,884	0,922	0,506
Kolaka	0,981	0,981	12,733	53,57	0,575	0,703	0,893	0,917	0,517
Konawe Selatan	0,974	0,974	12,420	50,59	0,546	0,787	0,894	0,931	0,495
Bombana	0,970	0,970	12,675	51,75	0,560	0,753	0,899	0,927	0,504
Wakatobi	0,971	0,971	12,912	50,96	0,562	0,759	0,902	0,928	0,506
Kolaka Utara	0,971	0,971	12,871	52,60	0,572	0,764	0,918	0,934	0,519
Buton Utara	0,973	0,973	13,561	53,94	0,602	0,695	0,918	0,923	0,541
Konawe Utara	0,969	0,969	13,123	52,77	0,580	0,730	0,876	0,916	0,515
Kolaka Timur	0,978	0,978	12,883	55,73	0,594	0,780	0,895	0,930	0,541
Konawe Kepulauan	0,967	0,967	11,998	50,81	0,536	0,735	0,902	0,925	0,480
Muna Barat	0,972	0,972	12,821	55,12	0,588	0,716	0,919	0,927	0,530
Buton Tengah	0,967	0,967	13,294	54,32	0,597	0,682	0,888	0,912	0,526
Buton Selatan	0,968	0,968	13,158	54,31	0,592	0,611	0,876	0,897	0,515
Kota Kendari	0,988	0,988	12,840	57,36	0,605	0,756	0,909	0,930	0,556
Kota Baubau	0,985	0,985	13,257	53,62	0,590	0,702	0,887	0,915	0,532
Prov. Gorontalo	0,969	0,969	12,991	52,91	0,577	0,761	0,880	0,922	0,516
Boalemo	0,971	0,971	12,994	53,79	0,584	0,920	0,874	0,947	0,537
Gorontalo	0,969	0,969	12,599	53,39	0,569	0,717	0,893	0,919	0,507
Pohuwato	0,962	0,962	12,655	51,80	0,560	0,820	0,845	0,921	0,497
Bone Bolango	0,967	0,967	13,205	52,76	0,583	0,770	0,885	0,925	0,521
Gorontalo Utara	0,962	0,962	12,834	48,70	0,544	0,744	0,870	0,917	0,480
Kota Gorontalo	0,977	0,977	13,868	55,88	0,627	0,688	0,891	0,914	0,560
Prov. Sulawesi Barat	0,968	0,968	12,850	51,39	0,563	0,646	0,872	0,902	0,491
Majene	0,964	0,964	13,638	48,58	0,564	0,625	0,844	0,890	0,484
Polewali Mandar	0,967	0,967	12,579	50,26	0,548	0,685	0,898	0,916	0,485
Mamasa	0,975	0,975	12,888	55,16	0,590	0,643	0,864	0,899	0,517
Mamuju	0,969	0,969	12,785	51,30	0,560	0,613	0,857	0,892	0,485
Mamuju Utara (Pasangkayu)	0,963	0,963	12,897	52,55	0,572	0,633	0,857	0,895	0,493
Mamuju Tengah	0,964	0,964	12,513	52,91	0,564	0,685	0,885	0,912	0,495
Prov. Maluku	0,969	0,969	12,820	50,43	0,555	0,717	0,850	0,906	0,488
Maluku Tenggara Barat	0,965	0,965	12,593	45,20	0,516	0,705	0,844	0,903	0,450

Wilayah	Angka Kelangsungan Hidup Balita	Dimensi Survival	HLS 4-18	Rata-rata skor AN	Dimensi Pendidikan	Proporsi Balita Bebas Stunting	Angka Kelangsungan Hidup Dewasa (15-60 tahun)	Dimensi Kesehatan	IMM 2025
(Kep. Tanimbar)									
Maluku Tenggara (Kep. Kei)	0,970	0,970	12,154	50,92	0,541	0,719	0,841	0,904	0,475
Maluku Tengah	0,972	0,972	13,049	52,26	0,574	0,730	0,834	0,904	0,504
Buru	0,969	0,969	12,664	49,53	0,545	0,746	0,878	0,919	0,486
Kepulauan Aru	0,968	0,968	12,191	42,69	0,493	0,624	0,789	0,874	0,417
Seram Bagian Barat	0,970	0,970	12,920	51,33	0,564	0,662	0,820	0,889	0,486
Seram Bagian Timur	0,954	0,954	12,980	41,83	0,504	0,650	0,802	0,882	0,424
Maluku Barat Daya	0,958	0,958	13,200	50,12	0,563	0,762	0,833	0,909	0,490
Buru Selatan	0,967	0,967	13,126	47,86	0,546	0,603	0,821	0,880	0,465
Kota Ambon	0,978	0,978	12,787	59,73	0,621	0,803	0,885	0,930	0,565
Kota Tual	0,970	0,970	12,610	48,73	0,539	0,748	0,888	0,923	0,482
Prov. Maluku Utara	0,969	0,969	12,747	44,65	0,516	0,768	0,854	0,916	0,458
Halmahera Barat	0,963	0,963	12,977	44,34	0,519	0,779	0,823	0,908	0,454
Halmahera Tengah	0,963	0,963	13,095	44,24	0,521	0,803	0,883	0,930	0,467
Kepulauan Sula	0,957	0,957	12,896	41,39	0,499	0,775	0,852	0,916	0,438
Halmahera Selatan	0,961	0,961	11,805	42,42	0,484	0,677	0,822	0,892	0,415
Halmahera Utara	0,974	0,974	12,840	43,40	0,510	0,782	0,824	0,909	0,452
Halmahera Timur	0,973	0,973	13,514	42,72	0,520	0,757	0,885	0,923	0,467
Pulau Morotai	0,967	0,967	12,280	43,19	0,498	0,823	0,818	0,914	0,440
Pulau Taliabu	0,971	0,971	11,736	44,30	0,493	0,751	0,830	0,906	0,433
kota Ternate	0,977	0,977	13,217	50,35	0,566	0,834	0,902	0,941	0,520
Kota Tidore Kepulauan	0,977	0,977	13,390	52,02	0,582	0,834	0,889	0,937	0,533
Prov. Papua Barat	0,957	0,957	12,240	47,11	0,520	0,753	0,868	0,918	0,456
Fakfak	0,975	0,975	12,191	47,41	0,521	0,790	0,877	0,926	0,470
Kaimana	0,959	0,959	12,017	43,09	0,492	0,798	0,819	0,910	0,429
Teluk Wondama	0,940	0,940	12,595	43,20	0,504	0,708	0,839	0,902	0,427
Teluk Bintuni	0,953	0,953	13,088	48,51	0,549	0,777	0,868	0,921	0,482
Manokwari	0,974	0,974	12,203	51,27	0,545	0,765	0,890	0,926	0,491
Manokwari Selatan	0,947	0,947	12,722	41,16	0,494	0,736	0,888	0,921	0,431
Pegunungan Arfak	0,952	0,952	9,757	43,95	0,452	0,607	0,846	0,888	0,382
Prov. Papua Barat Daya	0,967	0,967	12,589	50,30	0,549	0,695	0,872	0,909	0,482
Raja Ampat	0,952	0,952	11,953	45,08	0,502	0,626	0,832	0,887	0,423
Sorong	0,966	0,966	12,877	54,03	0,582	0,749	0,869	0,917	0,516
Sorong Selatan	0,951	0,951	11,996	50,36	0,534	0,687	0,829	0,896	0,455
Maybrat	0,947	0,947	13,070	44,40	0,522	0,693	0,877	0,911	0,450

Wilayah	Angka Kelangsungan Hidup Balita	Dimensi Survival	HLS 4-18	Rata-rata skor AN	Dimensi Pendidikan	Proporsi Balita Bebas Stunting	Angka Kelangsungan Hidup Dewasa (15-60 tahun)	Dimensi Kesehatan	IMM 2025
Tambrau	0,943	0,943	12,312	41,29	0,487	0,621	0,857	0,893	0,411
Sorong	0,978	0,978	12,630	53,65	0,572	0,707	0,886	0,915	0,512
Prov. Papua	0,967	0,967	12,180	50,48	0,539	0,753	0,876	0,920	0,480
Jayapura	0,967	0,967	12,590	49,41	0,543	0,775	0,887	0,927	0,486
Kepulauan Yapen	0,969	0,969	12,282	42,61	0,494	0,665	0,863	0,902	0,432
Biak Numfor	0,971	0,971	12,013	52,48	0,547	0,794	0,871	0,925	0,491
Sarmi	0,965	0,965	12,215	47,03	0,519	0,684	0,876	0,909	0,455
Keerom	0,963	0,963	11,665	51,70	0,533	0,756	0,877	0,921	0,473
Waropen	0,964	0,964	11,699	39,62	0,467	0,777	0,851	0,916	0,413
Supiori	0,962	0,962	12,242	43,95	0,501	0,625	0,836	0,888	0,428
Memberamo Jaya	0,957	0,957	10,792	45,54	0,480	0,662	0,866	0,902	0,414
Kota Jayapura	0,975	0,975	12,237	57,52	0,586	0,759	0,882	0,923	0,527
Prov. Papua Selatan	0,952	0,952	11,381	46,02	0,495	0,743	0,840	0,908	0,427
Merauke	0,970	0,970	12,548	48,91	0,539	0,815	0,880	0,931	0,486
Boven Digoel	0,954	0,954	12,242	45,74	0,512	0,698	0,850	0,903	0,441
Mappi	0,940	0,940	10,731	38,84	0,447	0,701	0,803	0,890	0,374
Asmat	0,948	0,948	9,756	48,60	0,472	0,717	0,769	0,883	0,395
Prov. Papua Tengah	0,954	0,954	8,826	49,43	0,455	0,675	0,828	0,893	0,388
Mimika	0,973	0,973	11,706	50,70	0,528	0,716	0,877	0,914	0,470
Dogiyai	0,940	0,940	8,590	46,97	0,441	0,442	0,840	0,861	0,357
Deiyai	0,944	0,944	5,279	38,97	0,366	0,694	0,781	0,883	0,305
Nabire	0,963	0,963	13,101	50,97	0,567	0,783	0,899	0,932	0,509
Paniai	0,960	0,960	6,876	44,81	0,403	0,704	0,790	0,887	0,343
Intan Jaya	0,944	0,944	7,880	30,77	0,379	0,516	0,763	0,851	0,304
Puncak	0,945	0,945	3,730	42,99	0,351	0,575	0,757	0,858	0,284
Puncak Jaya	0,953	0,953	7,511	40,10	0,401	0,637	0,837	0,890	0,340
Prov. Papua Pegunungan	0,949	0,949	8,840	45,49	0,441	0,600	0,806	0,876	0,366
Nduga	0,928	0,928	8,368	38,06	0,407	0,640	0,777	0,873	0,330
Jayawijaya	0,966	0,966	9,129	48,95	0,460	0,587	0,853	0,887	0,394
Lanny Jaya	0,953	0,953	11,747	44,61	0,495	0,646	0,829	0,889	0,419
Tolikara	0,948	0,948	6,717	46,59	0,405	0,536	0,732	0,845	0,325
Memberamo Tengah	0,960	0,960	8,191	47,17	0,434	0,580	0,853	0,886	0,369
Yalimo	0,956	0,956	10,219	43,36	0,458	0,649	0,816	0,886	0,388
Yahukimo	0,945	0,945	7,418	42,92	0,407	0,623	0,810	0,880	0,339
Pegunungan Bintang	0,944	0,944	7,853	42,25	0,412	0,586	0,734	0,853	0,332



BAB IV

Pemanfaatan IMM dalam Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia

**Pedoman Penghitungan Indeks Modal Manusia
dan Capaian Tahun 2025**



BAB IV

Pemanfaatan IMM dalam Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia

4.1. Integrasi IMM ke dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Indeks Modal Manusia (IMM) merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan sumber daya manusia berbasis bukti. Untuk itu, IMM perlu diintegrasikan ke dalam seluruh tahapan siklus perencanaan pembangunan daerah. Secara umum, IMM memiliki tiga peran utama, yaitu sebagai indikator capaian pembangunan sumber daya manusia, referensi dalam menetapkan prioritas pembangunan, serta instrumen untuk pemantauan dan evaluasi pembangunan sumber daya manusia. Melalui analisis nilai indeks beserta dimensi dan indikator penyusunnya, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi area yang masih memerlukan perhatian dan merumuskan kebijakan, program, serta intervensi yang lebih tepat sasaran. Tahapan integrasi IMM ke dalam proses perencanaan daerah disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Proses Integrasi IMM ke dalam Perencanaan Daerah

Tahapan	Aksi	Tujuan	Output
Analisis kondisi IMM daerah	Melakukan diagnosis nilai IMM berdasarkan masing-masing dimensi (kelangsungan hidup/ <i>survival</i> , pendidikan, dan kesehatan)	Mengidentifikasi dimensi yang menjadi kekuatan dan prioritas perbaikan berdasarkan capaian IMM daerah	Urutan prioritas dimensi pembangunan SDM berdasarkan nilai IMM
Identifikasi berdasarkan indikator penyusun IMM	Menganalisis capaian setiap indikator penyusun pada masing-masing dimensi IMM untuk mengidentifikasi indikator yang menjadi penyebab rendahnya nilai dimensi	Mengidentifikasi indikator yang perlu diprioritaskan untuk meningkatkan capaian setiap dimensi IMM	Daftar indikator prioritas yang harus ditingkatkan untuk meningkatkan nilai IMM

Tahapan	Aksi	Tujuan	Output
Analisis Determinan dan Pemetaan Program	Mengidentifikasi determinan yang memengaruhi indikator prioritas serta memetakan keterkaitannya dengan program pembangunan yang telah dilaksanakan	Mengidentifikasi akar permasalahan dan kesesuaian program pembangunan dalam mendukung peningkatan indikator prioritas IMM	Daftar keterkaitan antara indikator prioritas, determinan, dan program pembangunan sektoral
Perumusan dan penetapan program prioritas	Menetapkan program dan intervensi prioritas berdasarkan hasil analisis dimensi, indikator, determinan, dan program yang telah ditetapkan	Menetapkan prioritas intervensi yang paling efektif untuk meningkatkan nilai IMM sesuai karakteristik daerah	Penetapan program dan intervensi prioritas pembangunan SDM
Integrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah	Menggunakan hasil analisis nilai IMM, area prioritas pembangunan SDM, dan fokus indikator sebagai referensi dalam perumusan program pembangunan SDM untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	Menyusun perencanaan dan pembuatan kebijakan berbasis bukti (<i>evidence-based planning and policy-making</i>)	Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan SDM berbasis bukti

Gambar 4. Contoh Ilustrasi Analisis dan Pemanfaatan Hasil IMM

Tahap 1: Analisis Kondisi IMM Daerah

Nilai IMM Kabupaten Lestari Jaya sebesar 0,48, dengan capaian masing-masing dimensi sebagai berikut:

Kelangsungan hidup / <i>survival</i> (0,85)	Pendidikan (0,47)	Kesehatan (0,65)
---	-------------------	------------------

Kesimpulan sementara: Dimensi pendidikan dan kesehatan perlu menjadi prioritas.

Tahap 2: Identifikasi Berdasarkan Indikator Penyusun

Identifikasi indikator penyusun yang menjadi prioritas perbaikan untuk meningkatkan nilai IMM

Pendidikan	Kesehatan
- HLS masih rendah - Nilai AN pada aspek literasi membaca dan numerasi masih rendah	- Prevalensi <i>stunting</i> masih tinggi - Angka kematian penduduk produktif cukup tinggi

Hasil analisis: Peningkatan HLS, kualitas pembelajaran, penurunan *stunting* dan angka kematian menjadi prioritas peningkatan IMM.

Tahap 3: Analisis Determinan dan Pemetaan Program

Indikator prioritas dipetakan terhadap determinan dan program pembangunan yang relevan

Indikator Prioritas	Determinan	Program Pembangunan yang Relevan
HLS	Tingginya Anak Tidak Sekolah (ATS), putus sekolah, keterbatasan akses pendidikan	Pencegahan dan penanganan ATS, wajib belajar, bantuan pendidikan
Nilai AN	Keterbatasan jumlah guru berkualitas, kualitas pembelajaran belum merata, pemanfaatan teknologi pembelajaran belum optimal	Peningkatan kompetensi guru, transformasi pembelajaran, digitalisasi pendidikan
Prevalensi <i>stunting</i>	Cakupan ANC dan kunjungan neonatal belum memenuhi standar, deteksi dini dan intervensi gizi pada 1.000 HPK belum optimal	Percepatan penurunan <i>stunting</i>
Angka kematian penduduk usia produktif	Beban penyakit tidak menular masih tinggi, akses layanan kesehatan belum merata, akses sanitasi layak belum merata	Penguatan layanan kesehatan primer

Tahap 4. Perumusan dan Penetapan Program Prioritas

Berdasarkan analisis, pemerintah menetapkan 3 (tiga) program prioritas:

1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan

- Perluasan layanan pendidikan satu tahun prasekolah
- Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah
- Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas
- Inovasi pembelajaran berbasis teknologi dan pedagogi modern berbasis pada kebutuhan siswa (misal melalui metode *deep learning*)

2. Percepatan Penurunan *Stunting*

- Pemenuhan intervensi gizi sesuai siklus kehidupan, terutama 1.000 hari kehidupan
- Penguatan deteksi dini ibu hamil KEK dan balita berisiko gizi
- Penguatan tata laksana perbaikan gizi

3. Peningkatan Kelangsungan Hidup Dewasa Usia Produktif

- Penguatan deteksi dini dan tata laksana penyakit melalui inovasi teknologi kesehatan
- Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan di wilayah sulit akses
- Pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat serta penyehatan lingkungan

Tahap 5. Integrasi IMM ke dalam Dokumen Perencanaan

IMM digunakan sebagai instrumen utama dalam perencanaan dan penganggaran daerah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Integrasi fokus pembangunan SDM ke dalam RKPD
- Pengarahan APBD pada program pembelajaran dan kesehatan yang berdampak langsung terhadap IMM
- Pemantauan dan evaluasi capaian IMM kabupaten

Peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) memerlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah karena indikator penyusunnya berasal dari berbagai sektor yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Pemerintah daerah perlu menetapkan perangkat daerah penanggung jawab untuk setiap dimensi dan indikator penyusun IMM serta mengintegrasikannya ke dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan dokumen perencanaan lainnya. Dengan demikian, capaian IMM dapat ditelusuri hingga ke tingkat program, kegiatan, dan penganggaran sehingga akuntabilitas pelaksanaannya menjadi lebih jelas. Tabel 8 menyajikan perangkat daerah penanggung jawab utama untuk setiap indikator penyusun IMM. Penetapan perangkat daerah tersebut tidak menutup kebutuhan kolaborasi dengan perangkat daerah lain sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Sebagai contoh, upaya peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan, tetapi juga memerlukan dukungan perangkat daerah lain. Salah satu bentuk kolaborasi tersebut adalah dengan mengacu pada pembagian tugas Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah sesuai amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026.

Tabel 8. Pembagian Tanggung Jawab Perangkat Daerah dalam Peningkatan IMM

Indikator	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Mitra K/L
Angka kelangsungan hidup balita	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan
Harapan Lama Sekolah rentang usia 4-18 tahun	Dinas Pendidikan (berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama)	1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2. Kementerian Agama
Rata-rata nilai asesmen nasional	Dinas Pendidikan (berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama)	1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2. Kementerian Agama
Proporsi balita bebas <i>stunting</i>	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan
Angka kelangsungan hidup penduduk usia 15-60 tahun	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan

Peningkatan IMM juga memerlukan kolaborasi lintas kementerian/lembaga. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi prasyarat untuk meningkatkan kualitas modal manusia secara berkelanjutan.

4.2. Intervensi Peningkatan Indeks Modal Manusia

Peningkatan nilai IMM memerlukan intervensi yang menysasar faktor-faktor pembentuk modal manusia sejak awal kehidupan hingga memasuki usia produktif.

Prioritas intervensi disusun berdasarkan hasil pengukuran pada setiap dimensi dan indikator IMM sehingga kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan kualitas modal manusia.

Pertama, intervensi kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sepanjang siklus kehidupan melalui intervensi kelangsungan hidup anak, pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*, peningkatan kelangsungan hidup usia dewasa produktif, serta berbagai intervensi kesehatan lainnya, termasuk penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan cakupan imunisasi, peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan, deteksi dini dan penanganan risiko kesehatan, perbaikan gizi, pengendalian penyakit, perluasan akses layanan kesehatan berkualitas, serta penguatan perilaku hidup sehat. Kedua, intervensi pendidikan diarahkan pada peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, penguatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta penanganan anak tidak sekolah dalam meningkatkan capaian pembelajaran dan harapan lama sekolah. Upaya yang dilakukan secara terpadu diharapkan dapat meningkatkan kualitas modal manusia, produktivitas penduduk, dan nilai IMM secara berkelanjutan.

4.2.1. Intervensi Kesehatan

Intervensi kesehatan berperan besar dalam mencapai modal manusia yang unggul melalui intervensi kelangsungan hidup anak, pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*, kelangsungan hidup dewasa, dan berbagai intervensi kesehatan lainnya. Adapun detail intervensi kesehatan tersebut sebagai berikut.

A. Intervensi Kelangsungan Hidup Anak

- i. Penguatan cakupan dan kualitas layanan bayi baru lahir esensial (inisiasi menyusui dini, manajemen bayi berat lahir rendah, penanganan asfiksia neonatorum) di fasilitas kesehatan primer untuk mengantisipasi penyebab kematian neonatal.
- ii. Penguatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan neonatal esensial dasar (PONED) di Puskesmas dan pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif (PONEK) di rumah sakit yang terintegrasi dengan pemberdayaan kader dan Posyandu diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar dan sekaligus memastikan sistem rujukan yang cepat dan pemantauan pasca-perawatan di tingkat keluarga. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir semakin meningkat sehingga mampu menurunkan risiko kesakitan dan kematian ibu dan bayi.

- iii. Penguatan deteksi dini dan pengelolaan faktor risiko kematian ibu dan balita, termasuk peningkatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal, diarahkan untuk meningkatkan identifikasi, pencegahan, dan penanganan faktor risiko sejak dini.
- iv. Pemastian pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar, disertai penguatan literasi kesehatan bagi keluarga untuk mengenali tanda bahaya (*danger signs*) secara mandiri, serta penekanan pada Perawatan Metode Kangguru (PMK) bagi bayi berat lahir rendah (BBLR) diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan sejak kehamilan hingga masa neonatal melalui ANC, persalinan di fasilitas kesehatan, pelayanan nifas dan neonatal, layanan kegawatdaruratan, serta pemenuhan darah. Upaya ini diharapkan dapat menekan risiko kesakitan dan kematian ibu serta bayi.
- v. Penguatan imunisasi rutin diarahkan untuk mencegah kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), dengan perhatian khusus pada kesenjangan cakupan antarwilayah.
- vi. Penguatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) melalui optimalisasi peran kader dalam penjangkauan (*outreach*) aktif ke rumah-rumah, guna memastikan tidak ada anak yang terlewat dari perlindungan penyakit menular.
- vii. Peningkatan kolaborasi lintas sektor untuk pemenuhan akses air minum layak dan sanitasi dasar (STBM) di tingkat rumah tangga, mengingat kondisi lingkungan yang sehat merupakan faktor kunci dalam mencegah kematian balita akibat infeksi berulang.

B. Intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

- i. Pemenuhan paket layanan intervensi gizi sesuai kebutuhan kelompok sasaran pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0-23 bulan, serta kelompok sasaran lainnya, yaitu anak usia 24–59 bulan, remaja putri, calon pengantin, dan keluarga. Paket layanan mencakup, antara lain: pemantauan tumbuh kembang, *antenatal care*, penguatan pemberian makan (ASI eksklusif dan MP-ASI beragam), tata laksana balita gizi buruk, PMT pemulihan, imunisasi, air minum dan sanitasi aman, jejaring pengaman sosial, pendampingan keluarga, serta intervensi hulu bagi remaja putri dan calon pengantin (tablet tambah darah, skrining anemia, bimbingan perkawinan). Upaya ini didukung oleh penguatan konvergensi lintas sektor (integrasi data sasaran, administrasi kependudukan/NIK, pemanfaatan berbagai sumber anggaran) dan pendekatan berbasis konteks lokal, sehingga status gizi kelompok sasaran meningkat dan prevalensi stunting baru dapat dicegah.
- ii. Penguatan deteksi dini masalah gizi *pra-stunting* diarahkan untuk mengidentifikasi kelompok berisiko sejak awal melalui pemantauan ibu hamil

- Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita bermasalah gizi, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan sesuai standar.
- iii. Penguatan tata laksana perbaikan gizi dan penanganan faktor risiko diarahkan untuk meningkatkan kualitas intervensi gizi dan pencegahan *stunting*, melalui penerapan intervensi gizi sesuai standar, penyelesaian faktor risiko pada kelompok sasaran, serta penguatan integrasi layanan kesehatan dan gizi.
 - iv. Penguatan konvergensi dan analisis situasi berbasis kewilayahan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas percepatan penurunan *stunting* melalui koordinasi lintas sektor, pemanfaatan data, dan sinkronisasi intervensi pusat-daerah, sehingga program lebih tepat sasaran, terintegrasi, dan berkelanjutan.
 - v. Penguatan pencatatan kelahiran dan kematian beserta penyebabnya diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas data kelangsungan hidup, melalui pencatatan di dalam dan luar fasilitas kesehatan, penguatan pencatatan penyebab kematian, serta integrasi dengan sistem administrasi kependudukan, sehingga angka kematian dan kelangsungan hidup dapat dipantau secara lebih akurat hingga kabupaten/kota.

C. Intervensi Kelangsungan Hidup Usia Dewasa Produktif

- i. Penanggulangan penyakit dan pembudayaan hidup sehat diarahkan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit pada usia produktif. Kebijakan ini dilaksanakan melalui (a) penuntasan tuberkulosis, (b) eliminasi penyakit kusta dan schistosomiasis, (c) pengendalian penyakit menular lainnya terutama *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS) dan malaria, dan (d) pengendalian penyakit tidak menular serta peningkatan upaya kesehatan jiwa. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan beban penyakit dapat ditekan sehingga meningkatkan angka kelangsungan hidup usia dewasa produktif.
- ii. Penguatan deteksi dini dan tata laksana penyakit diarahkan untuk meningkatkan kemampuan sistem kesehatan dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani penyakit secara efektif. Kebijakan ini dilaksanakan melalui program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Melalui kebijakan tersebut, diharapkan penyakit dapat ditangani secara lebih cepat dan tepat sehingga menurunkan risiko komplikasi dan kematian pada usia produktif.
- iii. Pembudayaan hidup sehat dan penyehatan lingkungan diarahkan untuk menurunkan faktor risiko penyakit melalui penerapan perilaku hidup sehat dan pembangunan berwawasan kesehatan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, pengendalian konsumsi produk yang berdampak negatif bagi kesehatan, penerapan label gizi, penyediaan sarana

pendukung aktivitas fisik, serta penyehatan lingkungan. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan perilaku hidup sehat masyarakat semakin meningkat, faktor risiko penyakit dapat ditekan, dan angka kelangsungan hidup usia dewasa produktif terus meningkat.

D. Intervensi kesehatan lainnya

- i. Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pendanaan kesehatan diharapkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu semakin meningkat, disertai penguatan keberlanjutan pembiayaan kesehatan dan efektivitas penyelenggaraan JKN.
- ii. Produksi dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk pemenuhan dan pemerataan sesuai kebutuhan pembangunan kesehatan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui (a) peningkatan produksi SDM kesehatan, (b) peningkatan pendayagunaan SDM kesehatan, serta (c) peningkatan kapasitas SDM kesehatan. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan ketersediaan, pemerataan, dan kompetensi SDM kesehatan semakin meningkat sehingga pelayanan kesehatan dapat diberikan secara optimal di seluruh wilayah.
- iii. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan diarahkan untuk mewujudkan layanan kesehatan yang merata dan inklusif melalui penguatan layanan primer, pembangunan rumah sakit berkualitas, pengembangan layanan kesehatan bagi daerah sulit dijangkau, serta pemerataan tenaga kesehatan. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan layanan antarwilayah dan meningkatkan derajat kesehatan.

4.2.2. Intervensi Pendidikan

Intervensi pada dimensi pendidikan difokuskan pada peningkatan dua indikator utama, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 4-18 tahun serta hasil pembelajaran (*harmonized test score*). Kedua indikator tersebut mencerminkan akses terhadap pendidikan dan kualitas hasil belajar. Adapun intervensi yang mendukung peningkatan kedua indikator tersebut diuraikan sebagai berikut.

A. Indikator Harapan Lama Sekolah

- i. Peningkatan kecukupan gizi siswa dan santri yang dilengkapi dengan penguatan edukasi gizi melalui penguatan peran UKS/M agar dapat mendukung adanya perubahan perilaku makan sehat, bergizi seimbang, dan aman serta peningkatan kehadiran di sekolah. Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan program ini mencakupi peningkatan partisipasi sekolah dan

- kehadiran siswa, peningkatan prestasi belajar pada jangka panjang, penanaman kebiasaan perilaku makan sehat, dan peningkatan status gizi anak sekolah.
- ii. Perluasan layanan pendidikan anak usia dini diarahkan untuk mewujudkan pemerataan akses terhadap layanan pendidikan prasekolah yang berkualitas dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Perluasan layanan pendidikan anak usia dini dilaksanakan melalui penyediaan bantuan operasional satuan PAUD dan penyediaan bantuan afirmatif untuk PAUD. Melalui kebijakan perluasan layanan pendidikan anak usia dini, diharapkan pemerataan akses terhadap layanan pendidikan prasekolah yang berkualitas semakin meningkat sehingga mendukung kesiapan belajar dan tumbuh kembang anak secara optimal.
 - iii. Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas serta peningkatan kualitas pendidikan keagamaan diarahkan untuk mewujudkan pemerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, serta mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan memenuhi standar. Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah dilaksanakan melalui revitalisasi prasarana pendidikan dan pembangunan satuan pendidikan baru dan revitalisasi sarana pendidikan. Melalui kebijakan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah, diharapkan pemerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas semakin meningkat serta terwujud lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan memenuhi standar.
 - iv. Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran diarahkan untuk memperluas kesempatan memperoleh layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik, khususnya yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, dan kelompok masyarakat yang memerlukan afirmasi. Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran dilaksanakan melalui (a) penyediaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan bagi seluruh peserta didik, yang mencakup Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan, (b) penyediaan bantuan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu pada seluruh jenjang, termasuk PAUD, (c) penyediaan beasiswa prestasi dan beasiswa afirmasi, serta (d) pemenuhan akses pendidikan dasar universal. Kebijakan tersebut juga didukung melalui penyediaan bantuan perlengkapan sekolah (antara lain buku tulis dan alat tulis) untuk menunjang proses pembelajaran. Melalui kebijakan penyaluran bantuan pendidikan, diharapkan akses terhadap layanan pendidikan semakin merata, partisipasi

pendidikan meningkat, serta keberlanjutan pendidikan bagi peserta didik dapat terjaga.

- v. Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) merupakan langkah strategis nasional untuk menurunkan jumlah ATS serta menjamin terpenuhinya hak setiap anak atas layanan pendidikan yang berkualitas. Pencegahan dan penanganan ATS dilakukan melalui penyediaan layanan pendidikan yang beragam sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak, termasuk pada sekolah, madrasah, pendidikan kesetaraan, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan lainnya. Kebijakan ini juga mencakup afirmasi peningkatan akses pendidikan, pengasuhan, dan layanan kesejahteraan sosial secara terpadu bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Selain itu, penguatan edukasi pranikah dan pencegahan perkawinan anak diarahkan untuk mendukung keberlanjutan pendidikan serta mengurangi risiko putus sekolah akibat perkawinan pada usia anak. Melalui sinergi berbagai intervensi tersebut, diharapkan angka ATS terus menurun, akses terhadap layanan pendidikan semakin meningkat, serta pemerataan layanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan dapat terwujud.
- vi. Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi diarahkan untuk meningkatkan relevansi penyelenggaraan pendidikan tinggi serta memperluas partisipasi pendidikan tinggi dalam mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui (a) penyaluran bantuan pembiayaan pendidikan tinggi yang tepat sasaran, (b) pengembangan sarana dan prasarana perguruan tinggi berbasis teknologi, (c) inovasi dan perluasan layanan pendidikan tinggi, (d) penguatan kurikulum dan pembelajaran pendidikan tinggi, serta (e) pendidikan karakter, peningkatan kemampuan interpersonal, dan mobilitas akademik mahasiswa. Melalui kebijakan tersebut, akses terhadap pendidikan tinggi yang bermutu diperluas, kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi ditingkatkan, serta relevansi lulusan dengan kebutuhan pembangunan dan dunia kerja diperkuat guna mendukung peningkatan daya saing sumber daya manusia.

B. Indikator Hasil Pembelajaran

- i. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas diarahkan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kapasitas pendidik serta tenaga kependidikan dalam mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Kebijakan ini dilaksanakan melalui (a) reformasi pendidikan keguruan melalui penguatan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), (b) revitalisasi Pendidikan Profesi Guru (PPG), (c) peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui

- pelatihan berkelanjutan (*in-service training*) dan pengembangan profesional berkelanjutan, serta (d) penguatan pendampingan pembelajaran bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan kompetensi dan profesionalisme pendidik serta tenaga kependidikan semakin meningkat sehingga mampu mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan mendukung peningkatan hasil pembelajaran peserta didik.
- ii. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru yang meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional, perlindungan hukum, serta kesejahteraan berbasis kinerja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan guru sesuai dengan kebutuhan daerah, satuan pendidikan, dan mata pelajaran. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru dilaksanakan melalui (a) pemenuhan dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan, (b) pemenuhan kesejahteraan afirmatif pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengatasi kekurangan guru, (c) penguatan perencanaan dan kebijakan penyediaan Guru ASN, (d) peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, (e) peningkatan kesejahteraan guru agama berbasis kinerja, (f) peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja, serta (g) pendampingan pembelajaran bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Melalui kebijakan restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru, diharapkan ketersediaan dan pemerataan guru semakin optimal, kompetensi dan profesionalisme pendidik meningkat, serta kualitas pembelajaran di satuan pendidikan semakin baik.
 - iii. Pengembangan inovasi pembelajaran melalui penerapan pedagogi modern (*Pedagogical Technological Content Knowledge/PTCK*) dan pemanfaatan teknologi digital merupakan upaya mewujudkan pembelajaran yang inovatif serta meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Kebijakan pengembangan inovasi pembelajaran dilaksanakan melalui pemanfaatan platform digital pembelajaran untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, dan penyediaan akses listrik dan internet bagi satuan pendidikan. Kebijakan ini sejalan dengan program digitalisasi pendidikan sebagai langkah strategis dalam mempercepat pemerataan kualitas pendidikan nasional dan mempersiapkan generasi muda dengan keterampilan digital. Implementasi kebijakan digitalisasi pendidikan dilaksanakan melalui (a) pemerataan infrastruktur TIK dan akses internet, (b) penyediaan perangkat dan konten pembelajaran digital, serta (c) penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan. Dalam mendukung penyediaan konten pembelajaran digital, pengembangan Studio Guru diarahkan sebagai wahana produksi dan diseminasi materi pembelajaran berkualitas yang dapat diakses secara luas oleh satuan pendidikan. Melalui kebijakan ini, diharapkan

mendukung pengurangan kesenjangan pendidikan antarwilayah, peningkatan literasi digital, penguatan sistem penjaminan mutu pendidikan, serta terwujudnya pembelajaran yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing global.

- iv. Penciptaan ekosistem satuan pendidikan yang mendukung proses pembelajaran berkualitas, termasuk peningkatan kecakapan literasi kelas awal, serta penguatan karakter dan *wellbeing* peserta didik dan pendidik diarahkan untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter, sejahtera, dan mampu mengembangkan kompetensi sebagai warga masyarakat yang aktif, produktif, dan bertanggung jawab. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui (a) penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik dan pendidik pada satuan pendidikan, termasuk melalui pendidikan keagamaan yang menanamkan nilai integritas, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan etos kerja untuk memperkuat modal sosial sebagai bagian dari pembentukan modal manusia, (b) peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan ASN maupun non-ASN dalam bentuk finansial dan nonfinansial, serta (c) peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi peserta didik. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan tercipta lingkungan belajar yang aman, sehat, inklusif, dan mendukung pembentukan karakter, peningkatan kesejahteraan pendidik dan peserta didik, serta penguatan kualitas proses dan hasil pembelajaran.
- v. Pengembangan model layanan pendidikan terintegrasi bertujuan untuk mewujudkan pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan yang inklusif di seluruh wilayah sebagai fondasi dalam menghasilkan generasi yang berkarakter, kompeten, dan berdaya saing. Kebijakan ini dilaksanakan melalui pengembangan satuan pendidikan yang mengintegrasikan jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah untuk mewujudkan keterpaduan layanan pendidikan antarjenjang, kemudahan transisi peserta didik dalam melanjutkan pendidikan, pemerataan kualitas satuan pendidikan, serta membangun ekosistem pendidikan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
- vi. Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul diarahkan untuk mewujudkan terselenggaranya layanan pendidikan yang mampu menghasilkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing global. Pengembangan ekosistem sekolah unggul didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu penyeimbang, inkubator pemimpin, serta akademik dan pengabdian masyarakat. Pilar penyeimbang berfokus pada pemerataan kesempatan bagi peserta didik untuk meraih prestasi. Pilar inkubator pemimpin diarahkan

untuk membentuk karakter kepemimpinan sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Sementara itu, pilar akademik dan pengabdian masyarakat berfokus pada penyelenggaraan pendidikan berkualitas tinggi yang disertai pembinaan jiwa pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan semakin terbuka akses pendidikan berkualitas bagi peserta didik dari berbagai latar belakang daerah dan sosial ekonomi, terbentuk calon pemimpin bangsa yang berkarakter dan berdaya saing global, serta berkembangnya ekosistem pendidikan unggul yang mendorong keunggulan akademik, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.

- vii. Peningkatan kualitas dan relevansi lulusan pendidikan vokasi yang berdaya saing diarahkan untuk mewujudkan lulusan pendidikan vokasi yang produktif, berdaya saing, serta relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). Kebijakan ini dilaksanakan melalui (a) penguatan kemitraan antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, (b) penyelarasan kurikulum berbasis kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi, (c) peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi, (d) penguatan pembelajaran berbasis praktik kerja dan sertifikasi kompetensi, serta (e) penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran vokasi yang sesuai dengan standar industri. Melalui kebijakan tersebut, kualitas dan relevansi penyelenggaraan pendidikan vokasi ditingkatkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja, mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, dan mendukung peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia.



BAB V

Penutup

**Pedoman Penghitungan Indeks Modal Manusia
dan Capaian Tahun 2025**



N. FIRDAYS

STOP
PNEUMONIA!

ayo Cegah
gan Im

BAB V

Penutup

5.1. Disclaimer

Indeks Modal Manusia (IMM) dikembangkan untuk mendukung perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan sumber daya manusia di tingkat nasional maupun daerah. Dalam penghitungan IMM, beberapa indikator penyusun IMM menggunakan proksi dan penyesuaian metodologi sesuai dengan ketersediaan data di Indonesia. Pendekatan tersebut dipilih agar IMM dapat dihitung secara konsisten hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dengan tetap mempertahankan kerangka konseptual *Human Capital Index* (HCI) yang dikembangkan oleh *World Bank*.

Penggunaan indikator proksi dan penyesuaian metodologi telah melalui proses kajian serta konsultasi dengan kementerian/lembaga (K/L), Badan Pusat Statistik (BPS), pakar, dan *World Bank*. Berdasarkan kajian dan konsultasi tersebut, hasil IMM tahun 2025 dinilai telah memadai sebagai *baseline* awal pengembangan IMM di Indonesia. Selanjutnya, IMM dapat digunakan sebagai dasar pemantauan capaian pembangunan sumber daya manusia, identifikasi kesenjangan antarwilayah, serta penyusunan kebijakan dan intervensi pembangunan yang lebih tepat sasaran.

IMM perlu dipahami sebagai instrumen untuk memantau potensi produktivitas sumber daya manusia dan mengidentifikasi dimensi pembangunan yang masih memerlukan perhatian. Oleh karena itu, hasil IMM sebaiknya diinterpretasikan bersama dimensi penyusun dan indikator pendukung lainnya yang relevan, baik indikator yang menopang capaian IMM (misalnya angka kematian balita/AKBA, prevalensi *stunting*, dan angka partisipasi sekolah) maupun indikator yang didukung oleh kualitas modal manusia (misalnya tingkat kebugaran dan produktivitas tenaga kerja). Hal ini diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi pembangunan sumber daya manusia serta mendukung penyusunan intervensi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

5.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Keberlanjutan penghitungan IMM memerlukan penguatan tata kelola data untuk menjamin ketersediaan data yang sahih, konsisten, dan berkesinambungan sebagai dasar pengukuran pembangunan sumber daya manusia. Indikator penyusun

IMM bersumber dari berbagai sistem data sektoral dengan cakupan kewilayahan, siklus pengukuran, dan periode referensi yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melalui penyelarasan definisi, metadata, cakupan wilayah, serta periode referensi data. Penerapan prinsip Satu Data Indonesia juga perlu terus diperkuat melalui interoperabilitas dan mekanisme pertukaran data antarsektor, penggunaan kode referensi yang seragam, serta peningkatan kualitas data sehingga mendukung penghitungan IMM secara konsisten.

Di samping itu, penguatan metodologi perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan hasil penghitungan IMM memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan dapat menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan strategis. Penguatan tersebut mencakup penyempurnaan indikator, metode penghitungan, dan sumber data penyusun IMM seiring dengan perkembangan sistem statistik nasional dan meningkatnya kualitas data.

Seluruh proses tersebut perlu didukung oleh manajemen risiko yang terstruktur untuk mengidentifikasi, memantau, dan memitigasi berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan penghitungan IMM, termasuk ketepatan waktu publikasi, pemutakhiran data, representativitas, dan kualitas data. Penerapan manajemen risiko yang efektif diharapkan mampu menjaga keberlanjutan penghitungan, memastikan proses berjalan sesuai rencana, serta menghasilkan data yang akurat dan representatif sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

Keberlanjutan pengembangan IMM memerlukan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat tata kelola data, menyempurnakan metodologi secara berkala, menerapkan manajemen risiko secara berkelanjutan, serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengelolaan dan pemanfaatan IMM. Dengan dukungan tersebut, IMM diharapkan dapat menjadi instrumen yang andal dalam mendukung perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

DAFTAR PUSTAKA

- Angrist, N., Djankov, S., Goldberg, P. K., & Patrinos, H. A. (2021). Measuring human capital using global learning data. *Nature*, 592, 403-408.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susen) 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Duflo, E. (2001). Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia: Evidence from an Unusual Policy Experiment. *American Economic Review*, 91(4), 795-813. doi:10.1257/aer.91.4.795
- Kementerian Agama. (2025). *Education Management Information System cutoff semester Genap tahun 2025*. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- Kementerian Kesehatan. (2024). *Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024*. Jakarta: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). *Data Pokok Pendidikan cutoff semester Genap tahun 2025*. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). *Hasil Asesmen Nasional Tahun 2025*. Jakarta: Pusat Asesmen Pendidikan.
- Kraay, A. (2018). *Methodology for a World Bank Human Capital Index (Policy Research Working Paper No. 8593)*. Washington, DC: World Bank.
- Montenegro, C., & Patrinos, H. A. (2014). *Comparable Estimates of Returns to Schooling Around the World (Policy Research Working Paper No. 7020)*. Washington, DC: World Bank.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- United Nations Development Programme. (2020). *Human Development Report 2020 technical notes*. New York: United Nations Development Programme.
- Weil, D. N. (2007). Accounting for the effect of health on economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 122(3), 1265-1306.
- World Bank. (2018). *The Human Capital Project*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2020). *The Human Capital Index 2020 Update: Human Capital in the Time of COVID-19*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2024). *Funding Indonesia's Vision 2045: Indonesia Economic Prospects, December 2024*. Jakarta: World Bank Group.

**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Kantor Bappenas:
Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat 10310

Menara Bappenas:
Jalan H. R. Rasuna Said No. Kav. B2, Jakarta Selatan 12920

“

Mari bersama
Membangun Modal Manusia,
Mewujudkan
Indonesia Berdaya.